分类号：　　单位代码：10441

密　级：　　学　　号：201402226

山东中医药大学

硕士学位论文

中文题目：悬钟穴的古代文献研究

英文题目：The Acient Literature Study about Xuanzhong Acupoint（GB39）

申请人姓名　管素梅

入学年月　2014年9月

学科专业　针灸推拿学

指导教师　王　锐

学位类型　临床医学专业学位

2017年　6月　20日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立完成的，文中除注明引用的内容外，不包含任何其他已经发表的科研成果。对本文研究做出重要贡献者，均已在文中以明确方式表明。本声明的法律责任完全由自己承担。

论文作者签名 管素梅 导师签名 [illegible] 日期 _____

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东中医药大学有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门机构送交论文的复印件和电子版，允许被查阅和借阅。本人授权山东中医药大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复印手段保存和汇编本学位论文。

（保密论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名 管素梅 导师签名 [illegible] 日期 _____

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提　要

目的：本研究借助现代计算机检索技术与人工检索查阅相结合的方式，对涉及悬钟穴的相关古籍条文进行统计和整理，总结悬钟穴的有关内容，为现代临床和科研提供文献依据。

方法：以《中华医典》（第五版）为检索源，统计整理出悬钟穴的相关条文，建立数据库，再通过人工检索的形式对其进行核对，并应用 Microsoft Office Excel 表格进行统计分析。

结果：悬钟穴穴名有悬钟、绝骨、髓会、阳辅。归属于足少阳经。定位有直接定位与辅助定位两种定位方法，但主要以体表标志法为主。其单穴主治病证与配伍治疗病证有相似之处。治疗病证均涉及中医内科、外科、儿科、五官科，且主要为内科病证，其中肢体经络病证居于首位，但配伍治疗病证中增加了对中医妇科疾病的治疗。配伍腧穴较多，大部分为四肢部的十四经穴，涉及腧穴数目最多的经脉为足太阳膀胱经。同时对悬钟穴的刺灸法也进行了一定研究。

结论：该研究较为全面的理清了悬钟穴的古代应用特点，为现代临床和科研提供了文献依据。

关键词　悬钟；文献；主治病证；刺灸法；临床

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

The Acient Literature Study about Xuanzhong Acupoint（GB39)

Speciality: Acupuncture and Moxibustion

Author: Guan Sumei

Tutor: Prof. Wang Rui

Abstract

Objective: This research uses modern computer retrieval technology and artficial retrieval technology to collect, organize and sum up materials about Xuanzhong Acupoint(GB39) to provide literature basis for the modern clinical and scientific research.

Methods: By using the "Chinese Medical Classics"(The Fifth Edition) as the main data-sources to retrieve related to Xuanzhong Acupoint(GB39), establishing a database, then using Microsoft Office Excel Form to process the data.

Results: Xuanzhong Acupoint(GB39)has three names, including Xuanzhong, Juegu, Suihui,Yangfu. It belongs to the Foot Shaoyang gallbladder meridian. Use two location methods which are direct positioning and auxiliary positioning to locate it. It's single acupoint cure syndrome and compatibility of the main cure is similar. All involved in internal medicine, TCM surgery, pediatrics and so on. Internal medicine is the main. Body channels and collaterals disease is located in the first place, but the compatibility of disease increased the gynecopathy syndrome in TCM.Most of acupoint locates limbs, and belongs to the Foot Taiyang bladder meridian. Besides, the author analyzed the methods of acupuncture and moxibustion.

Conclusion: The research clarifies the ancient application characteristics of Xuanzhong Acupoint(GB39) better and provides literature basis for the modern clinical and scientific research.

Keyword Xuanzhong Acupoint(GB39);literature;cure syndrome;methods of acupuncture and moxibustion;clinical

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　　录

引　　言 1
研究目的与方法 2
1 研究目的 2
2 研究方法 2
2.1 源文献的选择 2
2.2 文献纳入标准 2
2.3 文献排除标准 3
2.4 文献剔除标准 3
2.5 条文的分类 4
2.6 数据库的建立 4
2.7 频数统计 4
2.8 结果分析 4
研究内容、结果与分析 5
1 穴名 5
2 定位 6
3 经脉归属 9
4 主治病证 10
4.1 悬钟穴单穴治疗病证 10
4.2 悬钟穴配伍治疗病证 12
4.3 悬钟穴配伍腧穴分析 22
5 刺灸法 25
5.1 针刺法 25
5.2 艾灸法 27
5.3 刺灸禁忌 28
结　　语 30
参考文献 32
综　　述 34

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

附　　录 40
致　　谢 44
发表论文 46

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

引　言

中华民族在数千年的生产和生活实践中研究人体生命、健康、疾病，积累了丰富的临床经验,并进行整理、总结，形成了中国传统医学--中医学。在诸多的中医治疗技术中，针灸疗法因其适应证广、疗效显著、操作方便、经济安全等特点发展较快，且取得的成就也较大。腧穴作为针灸治疗的一部分，既为疾病的反应点，又为治疗的施治点，在防治疾病方面有着举足轻重的地位。故理清腧穴的学术源流等基本情况；梳理腧穴主治病证，总结其证治规律；研究腧穴针灸操作方法等对为针灸临床提供参考具有重要意义。

悬钟穴的定位最早记载于《针灸甲乙经》:“悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”[1]即悬钟穴位于足外踝上三寸处，此处有动脉搏动，如果按压悬钟穴，则可使足背动脉无法触及。又名绝骨穴,为足少阳胆经穴,又是八会穴之髓会。《针灸穴名解》解释：“绝骨者，在胫腓二骨合并不着，中间隔绝之处”[2]。古代医籍对其适应症及临床应用记载繁多,如《针灸大全》云:“脚疼膝肿针三里,悬钟二陵三阴交”[3]等。历代古籍文献对悬钟穴虽有丰富的记载，但对此穴却一直缺乏系统的整理研究。因此，对悬钟穴的相关内容进行全面的系统梳理成为为针灸临床提供文献依据的重要任务。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研究目的与方法

1 研究目的

本研究借助现代计算机检索技术与人工检索查阅相结合的方式，通过系统整理古代的中医古籍中关于悬钟穴的相关内容，建立悬钟穴相关数据库，以期达到以下目的：

①理清悬钟穴穴名、定位、归经等情况；

②总结悬钟穴单穴及配伍主治病证，分析其证治规律，为针灸临床的选穴及配伍提供理论依据；

③总结悬钟穴刺灸方法、刺灸禁忌等特点。

2 研究方法

2.1 源文献的选择

以湖南电子音像出版社出版的《中华医典》（第 5 版）收录的 1000 余部书籍为数据源，分别以“悬钟”、“绝骨”、“髓会”、“阳辅”为检索词进行计算机检索，并摘录相关条文进行分类，建立数据库。再通过人工检索的形式对其进行核对。

2.2 文献纳入标准

（1）涉及悬钟穴穴名及别名的相关条文：

如：“悬钟二穴，一名绝骨。在足外踝上三寸，动脉是穴。”[4]（《针方六集·足少阳胆经所发四十四穴》）

（2）涉及悬钟穴定位的相关条文：

如：“悬钟，足三阳大络，在外踝上三寸动脉中按之。”[5]（《幼幼新书· 腹胀第七》）

（3）涉及悬钟穴经脉归属的相关条文：

如：“绝骨，外踝上光骨，当足少阳之悬钟。”[6]（《难经悬解·四十五难》）

（4）涉及悬钟穴单穴主治病证的相关条文：

如：“小儿腹满不能食饮，悬钟主之。”[7]（《圣济总录·治小儿诸疾灸刺法》）

（5）涉及悬钟穴配伍应用治疗疾病的相关条文：

如：“臌胀：气胀、寒胀，脾虚中满。针上脘、三里、章门、阴谷、关元、期门、行间、脾俞、悬钟、承满。”[8]（《针灸大成·杂病》）

（6）涉及悬钟穴刺灸法的相关条文：

如：“悬钟，在足外踝上三寸动者脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之，刺入

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

六分，留七呼，灸五壮。”[1](《针灸甲乙经·足少阳及股并阳维四穴凡二十八穴第三十四》)

（7）涉及悬钟穴刺灸禁忌的相关条文：

如：“妊娠二月，足少阳脉养，不可针灸其经（如胆窍、丘墟、跌阳、绝骨、外丘、阳陵泉等穴是也。）”[9](《备急千金要方·养胎第三》)

（8）涉及悬钟穴主治病证歌诀的相关条文：

如：“脚疼膝肿针三里，悬钟二陵三阴交。”[3](《针灸大全· 席弘赋》)

（9）涉及悬钟穴异名主治的相关条文：

如：“骭痠痛甚，按之不可，名曰胕髓病，以镵针针绝骨出其血，立已。”(《素问·刺疟篇》)

(10) 涉及悬钟穴主治病证的概述性的相关条文：

如：“悬钟二穴，在足外踝上三寸动脉中，足三阳之大络，按之阳明脉绝乃取之，治心腹胀满，胃中热不嗜食，膝胕痛，筋挛足不收履，坐不能起，可灸五壮，针入六分，留七呼。”[10](《圣济总录·足少阳胆经》)

（11）有关悬钟穴医论医案的条文：

如：“治冷痹胫膝痛。腰足挛急。足冷气上。不能久立。手足沉重。日觉羸瘦。此名复连病。宜灸悬钟。(绝骨。)一灸即愈。(见身湿痹千金。)。”[11](《针灸资生经·腰脚痛（余见腰膝)》)

2.3 文献排除标准

（1）悬钟穴辅助他穴定位的相关条文：

如：“丘墟，从悬钟行外踝下斜前陷中。灸三壮。”[12](《神灸经纶·胆经四十三穴分寸》)

（2）“悬钟”并非指悬钟穴的条文：

如：“然胎以脾胃为主，脾胃强则胎系如悬钟而不坠，若伤食不化则脾困而胎不能固。故凡即消食导滞，皆先以补脾健胃为主，而推扬谷气，则饮食自化。”[13](《冯氏锦囊秘录·妊娠伤食》)

2.4 文献剔除标准

由外国医家所编著和民国及其以后(1912 年以后)的医学著作中，涉及悬钟穴的相关条文：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

如：“巨阳少阳不动 吴云。巨阳。有委中。昆仑。少阳。有悬钟。听会。其脉皆不甚动。于其不甚动者。反动大疾。此阳厥善怒。而狂之候也。”[14]（《素问识·病能论篇第四十六》）。《素问识》一书为日本医家丹波元简撰写于日本，故剔除。

2.5 条文的分类

将符合纳入标准的条文录入，分为穴名、定位、经脉归属、主治病证、刺灸法五类。穴名为符合纳入标准（1）的条文，定位为符合纳入标准（2）的条文，经脉归属为符合纳入标准（3）的条文，刺灸法为符合纳入标准（6）的条文，主治病证为符合纳入标准（4）、（5）的条文。并将主治病证类条文分为单穴主治病证（符合纳入标准（4）的条文）、配伍主治病证（符合纳入标准（5）的条文），按照中医内科、外科、妇科、儿科、五官科等各科病证进行分类。

2.6 数据库的建立

2.6.1 病证病名的规范化。由于历代古籍跨越时间长，因此不同的时期记述病证病名的称谓会有一定的不同，这对统计结果并进行归纳会带来问题。因此病证病名采用新世纪（第二版）全国高等中医院校规划教材《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》等各科教材为标准进行分类。

2.6.2 离散处理复合病证。纳入的条文中有时会出现同一(组）穴位可治疗多种病证，此时即需要离散处理各种病证。如《针灸甲乙经·脾胃大肠受病发腹胀满肠中鸣短气第七》中“腹满，胃中有热，不嗜食，悬钟主之。”[15]，将其分为腹满、胃热、不嗜食三种病症。

2.6.3 建立数据库，录入条文。

2.7 频数统计

将所有纳入的条文分别进行频数统计。若有相同或相似的条文在同一古籍出现 2 次以上，或被不同古籍引用或转述重复出现，对此类条文统计时要累计计数。对条文中含义相近的一组病证要按一次统计，不重复计数。

2.8 结果分析

运用 Microsoft Office Excel，对悬钟穴进行归纳、整理，总结悬钟穴的基本源流及其主治病证等古代应用规律。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究内容、结果与分析

本课题通过对古籍中关于悬钟穴的穴位名称、经脉归属、定位、主治病证、刺灸法研究内容的相关文献资料进行搜集、检索、整理和分析，共涉及相关古籍书目125部。其中穴名为悬钟、绝骨、髓会、阳辅；定位有直接定位和辅助定位2种方法；归属经脉为足少阳胆经；单穴主治病证54种，多穴配伍主治病证61种；刺灸法以常规针刺和艾灸为主，常用针刺深度为六分，留针时间为七呼，常用灸法主要为三壮、五壮。具体结果分析如下：

1 穴名

古代文献中对悬钟穴穴名有“悬钟”、“绝骨”、“髓会”、“阳辅”这四种称谓。其中以“绝骨”见载最多。具体结果详见表1：

表1　悬钟穴穴名统计表

穴名	古籍	种类
绝骨	黄帝内经素问集注、素问吴注、黄帝内经素问、难经经释、肘后备急方、太平圣惠方、圣济总录 、鸡峰普济方 、普济本事方、世医得效方、万氏家抄济世良方、文堂集验方、凌门传授铜人指穴、针灸神书、医学实在易、扁鹊神应针灸玉龙经、卫生宝鉴、针灸聚英、针灸问对、明医指掌、针灸资生经、赤水玄珠、西方子明堂灸经、疡医大全、针灸大成、神应经、医述、针灸逢源、类经图翼、难经集注、考正周身穴法歌、医学要数、中西汇参铜人图说 、重楼玉钥、经脉图考、保命歌括、勉学堂针灸集成、医学正传、针方六集、神灸经纶、普济方、寿世保元、难经本义、古今医统大全、玉机微义、医学纲目、备急千金要方、千金翼方、外台秘要、金匮翼、证治准绳·杂病、医学从众录、证治准绳·疡医、外科理例、动功按摩秘诀、针经指南、急救广生集、本草纲目、研经言、医学原理、黄帝内经太素、类经、黄帝素问直解、素问悬解、素问病机气宜保命集、难经正义、脉经、仁斋直指方论（附补遗）、针灸大全、杨敬斋针灸全书、针灸素难要旨、类证普济本事方释义、万病回春、医学指归、医经小学、古本难经闸注、八十一难经、形色外诊简摩、针灸易学、医学入门、胤产全书、金匮启钥（妇科）、济阴纲目、医灯续焰、续名医类案、养生月览、育婴家秘、脚气治法总要、病机沙篆、医碥、兰台轨范、景岳全书、张氏医通、古今医鉴、丹溪心法、症因脉治、黄帝明堂灸经、叶氏录验方、针灸甲乙经、女科证治准绳、难经悬解、本草乘雅半偈、此事难知	103

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

悬钟	难经经释、类经、素问悬解、古本难经阐注、难经悬解、针灸大全、杨敬斋针灸全书、普济方、针灸聚英、针灸资生经、针灸大成、神应经、针灸逢源、类经图翼、考正周身穴法歌 、经脉图考、勉学堂针灸集成、针方六集、神灸经纶、古今医统大全、卫生宝鉴、景岳全书、医学纲目、备急千金要方、千金翼方、身经通考、医学指归、黄帝内经灵枢注证发微、黄帝内经灵枢集注、太平圣惠方、圣济总录、凌门传授铜人指穴、针灸神书、针灸甲乙经、扁鹊神应针灸玉龙经、经络汇编、针灸易学、黄帝明堂灸经、经络考、十四经发挥、中西汇参铜人图说、厘正按摩要术、丹溪手镜、医学入门、幼幼新书、外台秘要、外科大成、疡医大全、医学原理、内经知要、医经原旨、脉诀汇辨、脉贯、经络全书、刺灸心法要诀、灵枢经脉翼、医经小学、素问吴注、奇效良方、针经指南、杂病治例	61
髓会	难经经释、考正周身穴法歌、中西汇参铜人图说、素问悬解、古本难经阐注、八十一难经、难经悬解、杨敬斋针灸全书、针灸聚英、针灸问对、针灸资生经、针灸素难要旨、针灸大成、针灸逢源、类经图翼、勉学堂针灸集成、针方六集、子午流注针经、万病回春、卫生宝鉴、医学纲目、医学要数、中西汇通医经精义、难经正义、难经本义、普济方、针灸大全、扁鹊神应针灸玉龙经、针灸易学、经脉图考、医述、医学入门、形色外诊简摩	33
阳辅	难经集注、难经正义、难经本义、勉学堂针灸集成、扁鹊神应针灸玉龙经、针灸聚英、针灸素难要旨、古今医统大全	8

结果：

据统计，四种称谓中以“绝骨”见载最多，共计 103 种古籍；次之为“悬钟”，共计 61 种古籍；再之为“髓会”，共计 33 种古籍，最少的为“阳辅”，共计 8 种古籍。

分析：

悬钟一名最早见于《针灸甲乙经》云：“悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”[1]此古籍在提出悬钟之时，主要提出的是其定位。绝骨一名，最早见于《内经》,《针灸资生经》中将其作为悬钟的别名，指出：“悬钟二穴。在足外踝上三寸动脉中。针六分。留七呼。灸五壮。千云、一名绝骨。”[16]。髓会一名，与绝骨有密切联系，称为髓会绝骨，最早见于《难经·四十五难》：“髓会绝骨”[17]。在《针灸聚英》、《勉学堂针灸集成》等几部古籍中也有少量“髓会阳辅”、“绝骨一名阳辅”的说法。

2 定位

主要有直接定位与辅助定位两种定位方法，检索与阅读与悬钟穴及其别名定位的相关古籍条文，发现主要是以直接的体表标志作为定位的主要依据。其古籍统计结果见表 2、表 3。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　悬钟穴直接定位统计表

定位	古籍	频次
外踝上除踝三寸，必以绝陇处为穴	神应经 2 勉学堂针灸集成 2	4
在足内踝上三寸	太平圣惠方 1	1
在外踝上三寸宛宛中	太平圣惠方 1 普济方 1 黄帝明堂灸经 1 备急千金要方 1	4
在足外踝上三寸	扁鹊神应针灸玉龙经 2 圣济总录 2 素问吴注 1 针方六集 1 医学从众录 1 万氏家抄济世良方 1 明医指掌 1 赤水玄珠 1 千金翼方 1 证治准绳 · 杂病 1 急救广生集 1 针灸神书 1	14
悬钟三寸看绝骨	凌门传授铜人指穴 4 针灸聚英 2 古今医统大全 1	7
踝上三寸	黄帝内经灵枢注证发微 1 黄帝内经灵枢集注 1 经络汇编 1 经络考 1 针灸大全 1 针灸神书 1 刺灸心法要诀 1 针灸逢源 1 针灸问对 1 针灸大成 1 神应经 1	11
在足外踝上四寸	难经经释 3 普济本事方 1	4
足外踝上三寸动脉中，寻摸尖骨者是	中西汇参铜人图说 1 针灸聚英 1 针灸易学 1	3
在足外踝上三寸，当骨尖前动脉中，寻按取之。针灸经曰：寻摸尖骨者，乃是绝骨两分开，为足三阳之大络，按之阳明脉绝乃取之	圣济总录 1 针灸甲乙经 1 普济方 1 针灸聚英 2 针灸大成 2 针灸逢源 2 类经图翼 2 考正周身穴法歌 3 勉学堂针灸集成 3 针方六集 1 医学纲目 1 经脉图考 1 备急千金要方 1 古今医统大全 1	22
在足外踝上三寸动脉中	黄帝明堂灸经 1 针灸资生经 2 十四经发挥 1 黄帝内经素问集注 1 扁鹊神应针灸玉龙经 1 西方子明堂灸经 1 寿世保元 1 古今医统大全 2 玉机微义 1 医学实在易 1 卫生宝鉴 1 疡医大全 1 证治准绳 · 疡医 1 外科理例 1 医学原理 1 动功按摩秘诀 1	18
在足外踝上三寸绝垄前动脉中	针灸大成 2 勉学堂针灸集成 4 金匮翼 1	7
两踝相对为腕。内踝之前，大骨下陷中为然谷。外踝上为绝骨	素问要旨论 1	1
在外踝上三寸余，指端取踝骨上际，屈指头四寸便是，与下廉颇相对，分间二穴也	肘后备急方 1 普济方 1 圣济总录 1 针灸神书 1	4
在脚外踝上一寸	鸡峰普济方 1	1
在脚外踝上一夫，亦云四寸	世医得效方 1 备急千金要方 1 普济方 1 千金翼方 1	4
在足外踝上三寸，以踝上小骨绝处为是	中西汇参铜人图说 2 针方六集 1 卫生宝鉴 1 外台秘要 1 研经言 1	6

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结果：

由表 2 可知，悬钟穴的直接定位共 16 种，累计总频次 111，其中多数均以“ 外踝上三寸 ”为定位时的主要标志，涉及频次为 100。

分析：

笔者通过统计总结发现，对悬钟穴的定位主要以体表标志法为主，如：《针灸甲乙经》云：“ 悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”[1]、《圣济总录》“ 在足外踝上三寸动脉中，为足三阳之大络，按之阳明脉绝乃取之 ”[10] 等，都以“ 足外踝 ”这一体表标志作为定位时的关键依据，由此再进一步精确定位。除此之外，对悬钟穴定位中的某些描述，如：“ 在外踝上三寸宛宛中 ”也体现了古代的腧穴定位中具有体表形态这一明显特征。中医发展历史悠久，内容博大精深，其继承和发展的过程，会受到当时社会政治、经济、文化等的诸多影响，故其对文字的描述流传难免会有误差，如宋代《太平圣惠方》记载悬钟穴的定位“ 在足内踝上三寸 ”，但根据此古籍中其他地方的记载，和之前、之后的古籍记载，均记载其定位实为：在足外踝上三寸，可知其为记载的一个失误。再如《鸡峰普济方》有“ 在脚外踝上一寸 ”的记载，而其之前唐 · 孙思邈所著《备急千金要方》、《千金翼方》、与之后元 · 危亦林所著《世医得效方》、明 · 朱橚所著《普济方》均指出其定位在“ 绝骨穴，在脚外踝上一夫 ”，与之有一字之差。故可知其应为描述流传中的一个误差。并据其年代前后对“ 一夫 ”的描述可知为三寸，此描述与现代腧穴定位法中的“ 指寸 ”定位法中“ 一夫法 ”为三寸的描述相同。

表 3　悬钟穴辅助定位统计表

定位	古籍	频次
从阳辅下行三寸，外踝骨尖内动脉中，寻按取之	刺灸心法要诀 1 神灸经纶 1	2
外踝上三寸，附飞阳之前	文堂集验方 1	1

结果：

据表 3 可知，对悬钟穴的辅助定位记载较少，仅有 3 部古籍进行过 2 种描述，频次为 3。

分析：

借助其他穴位进行定位，有时可成为定位准确性时的一个辅助方面，如《文堂集

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

验方》中以“附飞阳”即跗阳穴辅助其定位。由此可知，悬钟穴虽位于外踝上三寸，但此范围有些许宽泛，不易进一步确定其具体位置，但有跗阳穴作为辅助的比较，进一步的增加了对悬钟位置的具体性。

3 经脉归属

对悬钟穴的经脉归属问题，历代医家均无异议，皆认为其归属于足少阳经。具体结果见表 4：

表 4　悬钟穴经脉归属统计表

归经	古籍	种类
循阳辅、悬钟，而下出外踝之前，至丘墟，循足面之临泣、五会、侠溪，乃上入小指次指之间，至窍阴而终	黄帝内经灵枢注证发微、黄帝内经灵枢集注、脉贯、经络汇编、针灸聚英、灵枢经脉翼、经络考、十四经发挥、经脉图考、医学指归、医学原理	11
足少阳经穴	类经	1
绝骨本名悬钟，足少阳经穴	素问悬解、类经	2
下行悬钟，循足面上之丘墟、临泣等穴，乃入小趾次趾之间，至窍阴穴，足少阳经止于此	类经、内经知要、医经原旨、经络全书、针灸逢源	5
阳辅悬钟穴可瞻。丘墟临泣地五会。侠溪窍阴胆经全	黄帝内经灵枢集注、黄帝内经灵枢注证发微、凌门传授铜人指穴、杨敬斋针灸全书、经络考、十四经发挥、针灸大成、中西汇参铜人图说、经脉图考、医学指归、医学入门、疡医大全	12
绝骨，外踝上光骨，足少阳悬钟穴	古本难经阐注、难经经释、难经悬解	3
阳辅 悬钟 丘墟 临泣 地五会 侠溪 窍阴	脉诀汇辨、针灸大全、针灸易学、刺灸心法要诀、类经图翼、神灸经纶、医经小学	7
绝骨，在足外踝上三寸，足少阳胆经穴也	素问吴注	1
少阳之经绝骨	素问病机气宜保命集	1
绝骨，属足少阳，即悬钟穴	难经经释	1
绝骨亦少阳穴	中西汇参铜人图说	1

结果：

据表 4 检索结果可知，历代文献中涉及悬钟穴经脉归属条文有 11 种描述，其中以“阳辅悬钟穴可瞻。丘墟临泣地五会。侠溪窍阴胆经全”[18]为记载最多，共涉及 12 部古代文献。

分析：

历代文献中涉及悬钟穴经脉归属条文大都以穴名在经脉循行分布的描述为主，如

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“下行悬钟，循足面上之丘墟、临泣等穴，乃入小趾次趾之间，至窍阴穴，足少阳经止于此”[19]，此种记载较为详细具体，或直接单纯以足少阳经的腧穴名称循经的分布表达其归属问题及经脉的走向，无其他叙述性的描述，如“阳辅 悬钟 丘墟 临泣 地五会 侠溪 窍阴”[20]，而此种记载则较为简单明了。

4 主治病证

4.1 悬钟穴单穴治疗病证

通过检索统计，悬钟穴单穴治疗病证颇多，统计结果如下：

表 5　悬钟单穴主治病证科别

科别	病证数	频次	累计频次	百分比（%）	累计百分比（%）
中医内科	49	649	649	85.51	85.51
中医外科	12	63	712	8.30	93.81
中医儿科	1	13	725	1.71	95.52
中医五官科	3	34	759	4.48	100.00
总计	54	759	759	100.00	100.00

据表可知，悬钟穴单穴治疗病证有 54 种，涉及科别有 4 种，总频次为 759。其中治疗主要病证为中医内科病证，可治疗 49 种，频次为 649，所占百分比为 85.51%；其次为中医外科病证，可治疗 12 种，频次为 63，所占百分比为 8.30%；再次为中医五官科病证，可治疗 3 种，频次为 34，所占百分比为 4.48%；治疗中医五官科、儿科病证较少，五官科中仅治疗“喉痹”、“鼻中干”、“耳鸣”三种病证，儿科病证最少，仅一种为“小儿腹满，不能饮食”。可知优势病证科别为中医内科和中医外科，统计结果见表 6：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6　悬钟单穴主治中医内科病证

属系病证	频次	百分比(%)	病证数	百分比(%)	病证（频次）
脾胃系病证	167	25.73	11	22.46	腹胀（5）纳呆（38）泄泻（11）便秘（11）奔豚（7）恶心（4）腹满（22）中焦寒热互结（1）吐酸（1）胃热（41）心腹胀满（26）
肾系病证	22	3.39	3	6.12	淋证（19）癃闭（1）水肿（2）
肢体经络病证	331	51.00	18	36.74	痹证（80）躄足（4）痉证（54）风身重（17）脚气（26）肘髓病（16）复连病（5）肫酸冷（6）髓病（19）厄痹（7）痿证（6）膝肫痛（41）项痹（20）腰痛（8）阴急（11）伛偻（3）足不收（5）足缓难行（3）
肝胆系病证	23	3.54	5	10.20	疟疾（3）头风（1）痫证（1）胁痛（4）中风（14）
肺系病证	26	4.01	2	4.08	咳嗽（25）胸中热（1）
心系病证	24	3.70	5	10.20	狂证（13）烦心（7）脑髓消（2）心悸（1）胸痹（1）
气血津液病证	56	8.63	5	10.20	鼻衄（14）伤寒（5）虚劳（19）忧恚（10）郁证（8）
总计	649	100.00	49	100.00	

结果：

可知，在中医内科病证中，治疗涉及 7 个属系病证，包括脾胃系、肾系、肢体经络、肝胆系、肺系、心系、气血津液。最多的是肢体经络病证和脾胃系病证。此两者治疗病证较多，且历代文献记载也集中，涉及频次也较多。其中前者治疗病证为 18 种，包括痹证、躄足、痉证、风身重、脚气、肘髓病、复连病、肫酸冷、髓病、厄痹、痿证、膝肫痛、项痹、腰痛、阴急、伛偻、足不收、足缓难行，频次为 331；后者为 11 种，包括腹胀、纳呆、泄泻、便秘、奔豚、恶心、腹满、中焦寒热互结、吐酸、胃热、心腹胀满，频次为 167。其余依次是气血津液、肺系、心系、肝胆系、肾系病证。

分析：

悬钟为足少阳胆经穴，足少阳胆经循行可从头面沿腿外侧至足，“经脉所过，主治所及”，而胆“是主骨所生病也”，故悬钟可治疗与骨有关的肢体经络病证。同时

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为八会穴之髓会，可治髓病。胆为六腑之一，可贮藏和排泄胆汁，促进饮食物的消化吸收输布等，而脾胃对饮食物受纳腐熟运化等功能，离不开胆的重要作用。胆的功能正常，有助于对饮食物的消化吸收和输布，使气血津液化生有源，更好的发挥“后天之本”的作用，濡养脏腑器官，肢体经络。同时胆经经脉、经别循行中有“入缺盆”、“合缺盆，以下胸中，贯膈”、“循胸里…以上挟咽…”等记载。胆主决断，而心藏神，为五脏六腑之大主，可调控胆的活动。肝为心之母，心为肝之子，肝胆相表里，胆的生理功能异常也会引起心的生理功能异常。肝经与胆经互为表里经，而且肝与胆亦有脏腑表里相合关系，所以两者在多个方面可相互联系，相互影响。肾为“先天之本”主骨生髓，而绝骨又为髓会，两者密不可分。故可知悬钟可治疗气血津液、肺系、心系、肝胆系、肾系等病证。

表 7　悬钟单穴主治中医外科病证

病证名称	频次	百分比(%)	病证数	百分比(%)	病证种类（频次）
疮疡病	40	63.49	7	58.33	疮疡（9）瘰疬（4）流注（5）痈（8）有头疽（10）附骨疽（3）疔疮（1）
肛肠疾病	19	30.16	3	25.00	肠痔（11）瘘（2）痔血（6）
皮肤疾病	4	6.35	2	16.67	湿疹（1）瘙痒（3）
总计	63	100.00	12	100.00	

由图表可知，悬钟穴单穴主治外科疾病，主要涉及疮疡疾病、肛肠疾病、皮肤疾病三类。其中病证种类、病证数、频次、百分比最多的是疮疡疾病。其次是肛肠疾病，最少的是皮肤疾病。《针灸大成》中有“悬钟主胃热腹胀，胁痛，脚气，脚胫湿痹，浑身瘙痒，趾疼。”[21]的记载。

4.2 悬钟穴配伍治疗病证

经检索，悬钟穴配伍治疗病证总数为 61，总频次为 454，具体情况如下：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 8　悬钟配伍治疗病证科别

科别	病证数	频次	累计频次	百分比（%）	累计百分比（%）
中医内科	39	399	399	87.89	87.89
中医外科	10	27	426	5.95	93.84
中医妇科	5	12	438	2.64	96.48
中医儿科	2	2	440	0.44	96.92
中医五官科	5	14	454	3.08	100.00
总计	61	454	454	100.00	100.00

结果：

由上述表格可知，悬钟穴配伍治疗病证有五个科别，包括中医内科、中医外科、中医妇科、中医儿科、中医五官科。其中，中医内科可治病证数为 39，频次为 399，百分比为 87.89%占首位；中医外科可治病证数为 10，频次为 27，百分比为 5.95%；中医五官科可治病证数为 5，频次为 14，百分比为 3.08%；中医妇科可治病证数为 5，频次为 12，百分比为 2.64%；中医儿科可治病证最少，病证数为 2，频次为 2，百分比为 0.44%。

分析：

悬钟穴配伍治疗病证与其单穴主治病证有相似之处。治疗病证均涉及中医内科、外科、儿科、五官科，且主要为内科病证，儿科治疗病证均最少。但配伍治疗病证中增加了对中医妇科疾病的治疗。可见中医在发展过程中不断摸索，寻查腧穴之间的联系，多穴相互配伍使用使其治疗范围有所增加。

4.2.1 配伍治疗内科病证

表 9　悬钟穴配伍治疗内科病证

属系病证	频次	百分比（%）	病证数	百分比（%）
肾系病证	6	1.50	2	5.13
脾胃系病证	11	2.75	4	10.26
肢体经络病证	226	56.64	13	33.33
心系病证	24	6.02	5	12.82
肝胆系病证	110	27.57	6	15.38
肺系病证	9	2.26	4	10.26
气血津液病证	13	3.26	5	12.82
总计	399	100.00	39	100.00

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由表可得，悬钟穴配伍治疗内科病证涉及属系全面，包括肾系、脾胃系、肢体经络、心系、肝胆系、肺系、气血津液。共可治疗 39 种病证，总频次为 399。其中肢体经络病证居于首位，治疗病证数为 13，频次为 226，其次为肝胆系、心系、气血津液病证。与此穴单穴治疗内科病证有相似之处。

4.2.1.1 肺系病证

表 10　肺系病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
喘证	2	风门（2）巨阙（2）太渊（2）期门（2）下脘（2）膻中（2）中脘（2）支沟（2）
感冒	3	通里（3）曲池（3）合谷（3）
咳嗽	2	风门（2）巨阙（2）太渊（2）期门（2）下脘（2）膻中（2）中脘（2）支沟（2）
胸胁支满	2	尺泽（2）太溪（2）神门（2）合谷（2）内关（2）中渚（2）

悬钟穴配伍治疗肺系病证主要有 4 种。包括喘证、感冒、咳嗽、胸胁支满。其中治疗喘证主要配伍风门、巨阙、太渊、期门、下脘、膻中、中脘、支沟；治疗感冒主要配伍通里、曲池、合谷；治疗咳嗽主要配伍风门、巨阙、太渊、期门、下脘、膻中、中脘、支沟；治疗胸胁支满主要配伍尺泽、太溪、神门、合谷、 内关、中渚。由此可看出悬钟穴配伍治疗肺系病证主要配伍任脉、肺经、大肠经、三焦经经穴。其中选用位于上焦部位的任脉经穴宽胸理气；用肺经本经腧穴发挥分经主治规律特点，治疗本经病变；肺与大肠相表里，两经互为表里经，通利大肠可调整肺的宣发肃降，影响其调畅气机及呼吸功能；三焦为“ 原气之别使 ”配伍三焦经穴可使畅达气的运行通道。少量配伍膀胱经、肝经、心经、肾经、心包经经穴以疏通气机，调畅呼吸，达到理肺行气、纳气平喘的功效。

4.2.1.2 肾系病证

表 11　肾系病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
水肿	2	照海（2）合谷（2）足三里（2）曲池（2）中脘（2）腕骨（2）脾俞（2）胃俞（1）人中（1）
淋证	4	复溜（2）太冲（2）气海（2）中极（2）曲骨（2）昆仑（2）肾俞（2）照海（2）三阴交（2）胃俞（1）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

悬钟穴配伍治疗肾系病证主要有 2 种。包括水肿和淋证。其中治疗水肿主要配伍照海、合谷、足三里、曲池、中脘、腕骨、脾俞、胃俞、人中；治疗淋证主要配伍复溜、太冲、气海、中极、曲骨、昆仑、肾俞、照海、三阴交、胃俞。由此可看出悬钟穴配伍治疗肾系病证主要配伍肾经、任脉、膀胱经经穴。其中选用肾经本经腧穴治疗本经病变，选用位于中、下焦部位的任脉经穴利水通淋，选用膀胱经中相应的穴位根据两经互为表里经治疗此类病证。少量配伍大肠经、小肠经、胃经、脾经、肝经以调理水液代谢。

4.2.1.3 脾胃系病证

表 12　脾胃系病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
腹满	3	中脘（3）足三里（3）章门（1）阴谷（1）关元（1）期门（1）行间（1）脾俞（1）承满（1）
霍乱	2	关冲（2）至阴（2）太冲（2）
纳呆	5	风门（2）巨阙（2）太渊（2）期门（2）下脘（4）膻中（2）中脘（2）支沟（2）足三里（2）金津（1）玉液（1）百会（1）玉泉（1）章门（1）心俞（1）
呕吐	1	中脘（1）商丘（1）大椎（1）中冲（1）胆俞（1）

悬钟穴配伍治疗脾胃系病证主要有 4 种，总频次为 11。包括腹满、霍乱、纳呆、呕吐。其中治疗纳呆频次最多，主要配伍风门、巨阙、太渊、期门、下脘、膻中、中脘、支沟、足三里、金津、玉液、百会、玉泉、章门、心俞。其中主要选用位于上、中焦的任脉穴以宽胸理气，行气和胃，治疗脾胃系病证，同时选用与脾胃有关的腧穴如期门、章门既为肝经穴可疏肝理气，调理脾胃，又分别为肝经和脾经的募穴，募穴为脏腑之气结聚于胸腹部的腧穴，可治疗相应的脏腑病，故又可健脾利胃治疗纳呆病证。治疗腹满主要配伍中脘、足三里、章门、阴谷、关元、期门、行间、脾俞、承满。治疗霍乱主要配伍关冲、至阴、太冲。治疗呕吐主要配伍中脘、商丘、大椎、中冲、胆俞。可知治疗脾胃系病证可采用近部选穴、远部选穴等选穴原则。

4.2.1.4 肝胆系病证

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 13　肝胆系病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
疟疾	17	百会（1）百劳（8）大椎（4）胆俞（2）风池（1）肝俞（3）膏肓（5）合谷（4）后溪（3）间使（5）曲池（5）足三里（3）三阴交（1）商丘（2）身柱（1）阴交（1）中冲（2）中封（3）中脘（2）
头痛	2	关元（2）肾俞（2）内关（2）胆俞（2）
黄疸	7	百会（7）承浆（2）胆俞（1）肺俞（3）肝俞（3）魂舍（2）夹脊（3）地仓（2）脾俞（1）气海（2）上脘（2）金津（2）玉液（2）肾俞（1）胃俞（1）下廉（4）小肠俞（1）心俞（5）玉泉（2）章门（2）风门（1）足阳明穴（2）颧髎（1）大肠俞（1）膀胱俞（1）风池（1）天窗（1）明堂（1）神庭（1）风府（1）
胁痛	10	肝俞（2）公孙（1）行间（4）内关（2）期门（6）足窍阴（3）足三里（3）神门（2）外关（3）阳陵泉（5）涌泉（2）鱼际（2）章门（7）支沟（2）中封（2）阴陵泉（2）
中风	71	百会（19）承浆（1）大椎（13）地仓（12）曲鬓（33）风池（16）间使（4）风市（64）行间（3）合谷（22）环跳（20）颊车（11）听会（1）肩井（15）列缺（9）丘墟（5）曲池（66）三间（1）足三里（65）三阴交（3）肩髃（44）昆仑（7）手三里（6）太渊（2）腕骨（3）囟会（4）阳陵泉（7）中封（1）二间（1）阳辅（1）委中（6）太冲（2）阳陵泉（1）照海（4）肝俞（2）申脉（1）　支沟（2）
臌胀	3	上脘（2）足三里（4）章门（2）阴谷（2）关元（2）期门（2）行间（2）脾俞（2）承满（5）中脘（1）通关（1）太白（1）公孙（1）复溜（1）水分（1）

悬钟穴配伍治疗肝胆系病证较多有 6 种，总频次为 110。其中记载频次最多的为中风，频次为 71。治疗配伍腧穴主要为胆经、大肠经经穴，中风病是由于阴阳失调，气血逆乱而导致的各种症状，根据胆经和大肠经的经脉循行，选用胆经腧穴风市、环跳、阳陵泉等，以及大肠经穴合谷、曲池、肩髃、手三里等可舒经通络，活血行气，不仅治疗体现了“ 经脉所过，主治所及 ”的原则，又可发挥局部治疗作用，同时还可以行气活血，可促进全身气血的运行，对机体整体气血有良好的调节作用。如《古今医统大全》中记载：“ 中风手足不遂等证：百会 发际 肩髃 曲池 风市 足三里 绝骨（一名悬钟）” [22]。疟疾频次为 17，主要配以膀胱经、大肠经经穴等以祛邪截疟；头痛频次为 2，配以关元、肾俞、内关、胆俞以益肾填精；黄疸频次为 7，主要配以膀胱经部分腧穴如胆俞、肺俞、肝俞、魂舍等以利湿退黄；胁痛频次为 10，主要配以肝经本经穴如期门、章门、中封等以疏肝利胆，行气止痛；臌胀频次为 3，主要配以足三里、章门、期门等以理气健脾。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2.1.5 心系病证

表 14　心系病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
癫狂	3	曲池（3）百劳（3）涌泉（3）
烦心	3	间使（2）神门（2）鱼际（2）心俞（2）脾俞（2）中脘（1）商丘（1）大椎（1）中冲（1）胆俞（1）
厥证	10	百会（1）大杼（2）大椎（1）胆俞（2）风池（1）风市（1）复溜（1）关元（2）合谷（3）环跳（2）间使（2）肩井（1）肩髃（2）昆仑（3）内关（2）曲池（2）人中（2）神阙（2）肾俞（6）太冲（4）太溪（2）足三里（5）阳陵泉（1）阴跷（1）照海（2）
心悸	5	飞扬（2）临泣（2）关元（2）肾俞（2）内关（2）胆俞（2）足三里（1）三阴交（1）
痫证	3	申脉（2）内庭（2）百会（2）间使（2）太渊（2） 曲池（1）足三里（2）肩髃（1）

悬钟穴配伍治疗心系病证有 5 种。包括癫狂、烦心、厥证、心悸、痫证。其中厥证的频次最多为 10。主要配伍膀胱经、胆经、肾经经穴。厥证的病变脏腑主要在心、肝，涉及到脾、肾，膀胱经与督脉相连，督脉入络脑，故可选用大杼、胆俞、肾俞以回阳醒神。肝与胆相表里，选用胆经穴如风池、风市、阳陵泉等祛风舒调经筋，而“心肾相交”，精神互用，选用肾经穴如复溜、太溪、照海可醒神回厥。癫狂频次为 3，配伍曲池、百劳、涌泉可醒脑开窍。烦心频次为 3，主要配伍心经、膀胱经穴以清心除烦。心悸频次为 5，主要配伍飞扬、肾俞、内关等以安神定悸。痫证频次为 3，配伍申脉、百会、间使、百会等以化痰开窍。

4.2.1.6 肢体经络病证

表 15　肢体经络病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
痹证	74	大杼（2）犊鼻（1）风市（8）复溜（2）公孙（1）行间（5）合谷（8）环跳（5）胛缝穴（2）肩井（3）肩髃（4）解溪（1）京骨（5）居髎（1）髋骨（1）昆仑（26）厉兑（2）足临泣（2）内关（2）丘墟（5）曲池（5）足三里（29）三阴交（39）商丘（1）申脉（3）神门（2）肾俞（4）中渚（2）太冲（27）天应穴（2）外关（4） 腕骨（2）委中（9）五枢（2）膝关（7）膝眼（1）足三里（7）阳辅（5）阳关（3） 阳交（2）阳陵泉（37）阴陵泉（29）支沟（2）中渎（3）中封（8）中脘（4）通里（2）
颤证	2	阳溪（2）曲池（2）腕骨（2）阳陵泉（2）公孙（2）太冲（22）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

胕酸冷	3	阳陵泉（1）中封（2）足临泣（1）足三里（9）阳辅（1）阴陵泉（1）风市（1）中渎（1）阳关（1）
脚气	48	冲阳（1）大椎（2）犊鼻（17）风市（35）行间（1）肩井（2）解溪（1）巨阙（1） 昆仑（4）膝眼（13）丘墟（1）足三里（44）三阴交（12）膻中（1）商丘（1）上廉（17）太冲（6）条口（1）通谷（1）侠溪（1）下廉（17）陷谷（2）阳辅（3）阳陵泉（8）阴交（2）阴陵泉（4） 照海（1）中封（1）曲泉（1）伏兔（1）中都（1）阳维（1）委中（1）
痉证	15	八邪（1）尺泽（1）大杼（2）胆俞（2）风市（4）关冲（2）关元（2）合谷（2）环跳（1）肩髃（1）京骨（1）昆仑（2）内关（2）曲池（1）曲泉（1）肾俞（5）太冲（4）委中（2）胃俞（1）足三里（3）阳辅（4）阳关（3）阳陵泉（5）阳溪（1）涌泉（2）至阴（2）中渎（3）中渚（1）
历节风	4	曲池（2）合谷（2）足三里（2）风池（2）胆俞（2）
髓病	2	大杼（1）上廉（1）
厄痹	3	阴陵泉（2）胆俞（2）风池（2）魂门（1）命门（1）外关（1）
痿证	24	百会（1）冲阳（3）大巨（2）犊鼻（9）飞扬（1）风市（8）跗阳（2）伏兔（2）公孙（2）合谷（2）环跳（2）肩井（2）肩髃（2）解溪（5）昆仑（4）梁丘（5）足临泣（1）前谷（3）曲池（2）曲泉（2）足三里（16）膻中（1）上廉（8）少海（1）申脉（2）太冲（5）天池（2）条口（3）膝眼（2）下廉（9）小海（1）阳辅（2）阳关（1）阳陵泉（7）阴交（1）阴陵泉（6）支沟（2）中渎（1）中封（1）三阴交（5）复溜（5）中渚（1）然谷（5）涌泉（5）足太阳（1）足太阴（4）承山（5）束骨（5）
膝胕痛	28	风市（1）行间（1）环跳（2）居髎（2）足三里（25）三阴交（24）太冲（25）委中（2）膝眼（1）阳关（1）阳陵泉（25）阴陵泉（24）中渎（1）
项痹	4	风门（4）肩井（4）风池（4）昆仑（4）天柱（4）风府（4）阿是穴（4）
伛偻	3	曲池（3）人中（3）风池（3）
足缓难行	16	冲阳（13）条口（12）肾俞（2）环跳（2）风市（2）犊鼻（2）膝关（2）阳陵泉（2）阴陵泉（2）足三里（3）

悬钟穴配伍治疗肢体经络病证最多，有 13 种。频次为 226。包括痹证、颤证、胕酸冷、脚气、痉证、历节风、髓病、厄痹、痿证、膝胕痛、项痹、伛偻、足缓难行。其中痹证记载最多，频次为 74。主要配伍胆经、膀胱经、胃经、脾经、肝经经穴。少量配伍大肠经、三焦经、肾经、心经、心包经、小肠经、任脉穴、阿是穴。选用胆经穴既体现了循经选穴的原则，也体现了腧穴分部主治的特点，膀胱经“是主筋所生病者…项、背、腰、尻、腘、踹、脚皆痛，小指不用。”脾经、胃经与脾、胃脏腑相关，而脾胃为“后天之本”，为气血生化之源。通过调理后天，可滋养筋脉，舒畅筋骨。肝经、胆经互为表里经，通过两经相配可发挥疏通经络，调理脏腑的作用。其次

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为脚气，频次为 48，治疗脚气，主要选用膝关节以下的腧穴如丘墟、足三里、三阴交、阳辅、阳陵泉进行局部治疗。膝胕痛频次为 28，主要选用的也是位于膝关节附近的腧穴舒筋活血，行气止痛。对于痿证的治疗主要配伍脾经、胃经位于下肢的腧穴，如足三里、三阴交、梁丘、阴陵泉等以培补后天，补益气血。治疗足缓难行主要配伍胆经、胃经下肢的腧穴，如冲阳、条口、阳陵泉等以滋养经筋。配伍曲泉、悬钟、阳辅穴等膀胱经、胆经等经穴可养血止痉治疗痉证。与曲池、合谷、足三里、风池、胆俞配伍应用可活血止痛治疗历节风。配伍风门、肩井、风池、昆仑、天柱、风府、阿是穴可疏风活血，行气止痛治疗项痹。对于配伍曲池、人中、风池治疗伛偻，集中体现在歌赋《玉龙赋》中。对于厥痹，《针灸大成》中有如下记载：“百节酸痛：魂门、绝骨、命门、外关”[23]。如《医学纲目》：“髀筋急胫痛，纵缓痿痹，腨疼膝冷，外廉不可屈伸，湿痹流肿：风市、中渎、阳关、悬钟”[24]，配伍足三里、阳陵泉、中封等可补益气血治疗胕酸冷。配伍阳溪、曲池、腕骨、阳陵泉、公孙、太冲可发挥行气活血，濡养筋脉的作用以治疗颤证。《针灸资生经》等古籍中有“髓会绝骨。髓病治此”[25]等记载。

4.2.1.7 气血津液病证

表 16　气血津液病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
鼻衄	5	风府（2）迎香（2）太冲（2）合谷（2）大陵（2）尺泽（2）神门（2）上星（3）囟会（3）
尿血	2	昆仑（2）肾俞（2）照海（2）
伤寒	2	合谷（1）曲池（1）液门（1）复溜（1）飞扬（1）足临泣（1）
伤寒热病	2	风门（2）合谷（2）行间（2）曲池（2）百劳（2）涌泉（2）
虚劳	2	昆仑（2）肾俞（2）照海（2）

悬钟穴配伍治疗气血津液病证有 5 种。其中鼻衄与尿血均属于血证，但为详细论述，故分开统计。鼻衄频次最多，为 5。配伍风府、迎香、上星、太冲、合谷、大陵、尺泽、神门、囟会穴，体现了近部取穴、远部取穴与辨证对症取穴相结合的选穴原则。尿血配伍昆仑、肾俞、照海以清热凉血。伤寒与伤寒热病症状有相同的部分，故可采用合谷、曲池相同的腧穴，再辨证选穴进行具体的治疗。虚劳因气血阴阳虚衰所致，故配伍昆仑、肾俞、照海以益气养血补肾。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2.2 配伍治疗外科病证

表 17　外科病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
疮疡	15	尺泽（1）风市（2）行间（5）合谷（7）间使（7）解溪（7）京骨（1）昆仑（1）内关（1）曲池（7）足三里（11）神门（1）太冲（1）阳辅（3）三阴交（1）膝眼（2）委中（10）照海（1）中封（3）中渚（1）
丹毒	1	足三里（1）三阴交（1）委中（1）
附骨疽	1	大陵（1）昆仑（1）
臁疮	1	气海（1）解溪（1）
流注	1	风市（1）中渎（1）阳关（1）
瘰疬	2	行间（2）神门（2）太渊（2）胆俞（2）腕骨（2）
瘙痒	2	百会（2）太阳（2）百劳（2）命门（2）风市（2）水分（2）气海（2）血海（2）
瘾疹	1	曲池（1）委中（1）
痈疽	1	委中（1）尺泽（1）太冲（1）曲池（1）神门（1）中渚（1）合谷（1）内关（1）申脉（1）太渊（1）照海（1）昆仑（1）心俞（1）肺俞（1）胃俞（1）脾俞（1）
疝	2	大敦（2）三阴交（2）太冲（2）

悬钟穴配伍治疗外科病证有 10 种。频次为 27。虽病证种类较多，但论述较少。疮疡主要因外感、内伤致病因素所导致，故配伍膀胱经、肝经、胆经、大肠经等经穴清热祛湿，泻火解毒，因心主诸痛痒疮，心包代心受邪，故可同时配合心经、心包经等经穴止痒止痛。其余各证，记载较少，记述如：《神灸经纶》：“ 附骨疽 生脚外鱼肚上一云环跳穴痛恐生附骨疽也。大陵、悬钟、昆仑、兑疽、生臂上兑肉端 ”[26]。

4.2.3 配伍治疗妇科病证

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 18　妇科病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
崩漏	4	中极（2）三阴交（2）百劳（4）风门（3）肾俞（4）膏肓（4）曲池（4）丹田（1）子宫（2）风池（1）中极（3）
产后身痛	1	环跳（1）五枢（1）曲池（1）液门（1）
妇人疟疾	2	风门（2）太渊（1）中脘（1）曲池（1）间使（2）魂户（1）支沟（1）太溪（1）
五心烦热	4	百会（2）膏肓（3）曲池（3）合谷（3）肾俞（3）风门（1）魂户（1）支沟（1）间使（1）太溪（1）太渊（1）太白（1）中府（1）
阴痛	1	昆仑（1）肾俞（1）照海（1）

悬钟穴配伍治疗妇科病证有 5 种。频次为 12。包括崩漏、产后身痛、妇人疟疾、五心烦热、阴痛。治疗崩漏与女人血气劳倦五心烦热，均主要配伍膀胱经经穴，膀胱经与督脉相连，督脉为“阳脉之海”，主一身之阳气，同时督脉循行，“起于胞中，下出会阴”与任脉、冲脉“一源三歧”，三者密切相关，对妇女的经带胎产有重要意义。古代文献中，对妇人疟疾、产后身痛、阴痛的记载较少，如《医学纲目》：“妇人四旬，因小产成病，百节痛，无常处，卧床不起，八字（五分），环跳（四寸半），五枢（三寸半），曲池、液门（各寸半），绝骨（二寸半）。”[27]。

4.2.4 配伍治疗儿科病证

悬钟穴配伍治疗儿科病证仅有小儿疮疡、小儿腹满不能食 2 种。仅在《针灸聚英》、《普济方》中有记载。古代运用悬钟穴配伍治疗儿科病证具有取穴少的特点，但同时因其所载数量太少，故缺乏一定的代表性。

4.2.5 配伍治疗五官科病证

表 19　五官科病证

病证名称	频次	配伍腧穴（频次）
鼻鼽	4	风府（2）迎香（2）上星（2）太冲（2）合谷（2）大陵（2）尺泽（2）神门（2）风门（2）巨阙（2）太渊（2）期门（2）下脘（2）膻中（2）中脘（2）支沟（2）
耳聋	4	百会（2）合谷（2）腕骨（2）中渚（2）后溪（2）足三里（2）昆仑（4）肾俞（4） 照海（2）
喉痹	2	尺泽（2）太溪（2）神门（2）合谷（2）内关（2）中渚（2）
口苦	2	足三里（2）然谷（2）神门（2）
目赤肿痛	2	合谷（2）昆仑（2）神门（2）风池（2）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

悬钟穴配伍治疗五官科病证有 5 种。频次为 14。包括鼻鼽、耳聋、喉痹、口苦、目赤肿痛。涉及耳鼻喉口眼，治疗范围较全面。其中因鼻鼽与鼻衄均属于鼻部的病变，有相似的针刺配伍穴位，如风府、迎香、上星、太冲、合谷、大陵、尺泽、神门。对于耳聋的配伍取穴，以远端取穴为主，同时以膀胱经穴为主，此经“从巅至耳上角”，且膀胱与肾相表里，肾开窍于耳。同时还配伍小肠经、三焦经等经穴，与其循行与耳亦有关，体现了循经取穴的原则。喉痹配伍尺泽、太溪、神门、合谷、内关、中渚以清热利咽，消肿止痛治疗。口苦配伍足三里、然谷、神门以清热祛湿。目赤肿痛配伍合谷、昆仑、神门、风池以清泻风热，消肿定痛。

4.3 悬钟穴配伍腧穴分析

4.3.1 悬钟穴配伍治疗病证中，涉及的配伍腧穴较多，具体统计如下：

表 20　悬钟穴配伍腧穴表

穴位	频次	百分比(%)	穴位	频次	百分比(%)	穴位	频次	百分比(%)
中府	1	0.04%	足窍阴	3	0.12%	膏肓	12	0.49%
八邪	1	0.04%	五枢	3	0.12%	解溪	12	0.49%
大肠俞	1	0.04%	陷谷	3	0.12%	丘墟	12	0.49%
颧髎	1	0.04%	阳溪	3	0.12%	听会	12	0.49%
丹田	1	0.04%	阴谷	3	0.12%	中渚	12	0.49%
二间	1	0.04%	玉泉	3	0.12%	复溜	13	0.53%
行谷	1	0.04%	飞扬	4	0.16%	腕骨	13	0.53%
魂门	1	0.04%	关冲	4	0.16%	章门	13	0.53%
绝骨	1	0.04%	曲泉	4	0.16%	地仓	14	0.57%
髓骨	1	0.04%	天柱	4	0.16%	期门	15	0.61%
明堂	1	0.04%	迎香	4	0.16%	涌泉	15	0.61%
膀胱俞	1	0.04%	鱼际	4	0.16%	条口	16	0.66%
三间	1	0.04%	至阴	4	0.16%	伏兔	17	0.70%
下廉	1	0.04%	中冲	4	0.16%	百劳	18	0.74%
少海	1	0.04%	足太阴	4	0.16%	冲阳	18	0.74%
身柱	1	0.04%	承山	5	0.20%	内关	18	0.74%
神庭	1	0.04%	大陵	5	0.20%	胆俞	19	0.78%
天窗	1	0.04%	肺俞	5	0.20%	太渊	19	0.78%
通谷	1	0.04%	梁丘	5	0.20%	膝眼	19	0.78%
通关	1	0.04%	上脘	5	0.20%	支沟	19	0.78%
侠溪	1	0.04%	束骨	5	0.20%	阳辅	20	0.82%

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

小肠俞	1	0.04%	通里	5	0.20%	中封	21	0.86%
小海	1	0.04%	阿是穴	6	0.25%	间使	22	0.90%
阳维	1	0.04%	人中	6	0.25%	神门	22	0.90%
中都	1	0.04%	商丘	6	0.25%	照海	22	0.90%
足太阳	1	0.04%	胃俞	6	0.25%	大椎	23	0.94%
液门	2	0.08%	后溪	7	0.29%	风门	24	0.98%
大巨	2	0.08%	足临泣	7	0.29%	中脘	24	0.98%
跗阳	2	0.08%	气海	7	0.29%	上廉	26	1.06%
魂户	2	0.08%	然谷	7	0.29%	肩井	27	1.11%
魂舍	2	0.08%	上星	7	0.29%	下廉	28	1.15%
胛缝穴	2	0.08%	囟会	7	0.29%	犊鼻	29	1.19%
厉兑	2	0.08%	中极	7	0.29%	行间	29	1.19%
内庭	2	0.08%	大杼	8	0.33%	曲鬓	32	1.31%
曲骨	2	0.08%	公孙	8	0.33%	委中	35	1.43%
子宫	2	0.08%	京骨	8	0.33%	环跳	36	1.47%
神阙	2	0.08%	手三里	8	0.33%	风池	39	1.60%
水分	2	0.08%	太溪	8	0.33%	肾俞	42	1.72%
太白	2	0.08%	外关	8	0.33%	肩髃	63	2.58%
太阳	2	0.08%	下脘	8	0.33%	昆仑	71	2.91%
天池	2	0.08%	风府	9	0.37%	阴陵泉	71	2.91%
血海	2	0.08%	巨阙	9	0.37%	百会	78	3.19%
阳交	2	0.08%	列缺	9	0.37%	合谷	80	3.28%
阴跷	2	0.08%	肝俞	10	0.41%	太冲	88	3.60%
足阳明	2	0.08%	脾俞	10	0.41%	三阴交	100	4.10%
承浆	3	0.12%	膻中	10	0.41%	阳陵泉	104	4.26%
承满	3	0.12%	申脉	10	0.41%	风市	117	4.79%
大敦	3	0.12%	膝关	10	0.41%	曲池	124	5.08%
夹脊	3	0.12%	心俞	10	0.41%	足三里	243	9.95%
居髎	3	0.12%	阳关	10	0.41%			
金津	3	0.12%	阴交	10	0.41%			
玉液	3	0.12%	中渎	10	0.41%			
承浆	3	0.12%	颊车	11	0.45%			
命门	3	0.12%	关元	11	0.45%			
前谷	3	0.12%	尺泽	11	0.45%			

由表可知，悬钟穴配伍治疗病证中，涉及的配伍腧穴共 159 个。腧穴涉及频次不等，涉及范围较广。其中大部分为十四经穴位，所占比例较大。使用频次居于前五位

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的依次有：足三里，使用频次最多为 243 次；曲池使用频次为 127 次；风市使用频次为 117 次；阳陵泉使用频次为 104 次；三阴交使用频次为 100 次。可大体看出使用频次较多的多为四肢部腧穴，头面、躯干部腧穴使用频次相对较少。

4.3.2 悬钟穴配伍腧穴归经分析

表 21　悬钟穴配伍腧穴归经表

经脉	腧穴数	总频次	百分比(%)	配伍腧穴（频次）
足太阳膀胱经	23	316	13.93	大肠俞（1）魂门（1）膀胱俞（1）昆仑（71）肾俞（42）委中（35）大椎（23）胆俞（19）膏肓（12）心俞（10）申脉（10）脾俞（10）肝俞（10）风门（24）京骨（8）大杼（8）胃俞（6）束骨（5）肺俞（5）承山（5）天柱（4）飞扬（4）魂户（2）
足太阴脾经	6	189	8.33	三阴交（100）阴陵泉（71）公孙（8）商丘（6）血海（2）太白（2）
足阳明胃经	15	379	16.70	足三里（243）犊鼻（29）冲阳（18）伏兔（17）条口（16）地仓（14）解溪（12）颊车（11）梁丘（5）陷谷（3）承满（3）内庭（2）厉兑（2）跗阳（2）大巨（2）
任脉	13	100	4.41	关元（11）阴交（10）膻中（10）巨阙（9）下脘（8）中脘（24）中极（7）曲骨（2）气海（7）上脘（5）承浆（3）水分（2）神阙（2）
足少阴肾经	6	68	3.00	照海（22）涌泉（15）复溜（13）太溪（8）然谷（7）阴谷（3）
足厥阴肝经	9	173	7.63	太冲（88）行间（29）中封（21）期门（15）章门（1）膝关（10）曲泉（4）大敦（3）中都（2）
足少阳胆经	14	421	18.55	风市（117）阳陵泉（104）风池（39）环跳（36）曲鬓（32）肩井（27）阳辅（20）听会（12）丘墟（12）中渎（10）至阴（4）五枢（3）居髎（3）阳交（2）
手少阳三焦经	5	45	1.98	支沟（19）中渚（12）外关（8）关冲（4）液门（2）
手阳明大肠经	10	338	14.90	上廉（26）二间（1）三间（1）下廉（28）曲池（124）合谷（80）肩髃（63）手三里（8）迎香（4）阳溪（3）
手太阴肺经	5	45	1.98	太渊（19）尺泽（11）列缺（9）鱼际（4）中府（2）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

手厥阴心包经	5	51	2.25	间使（22）内关（18）大陵（5）中冲（4）天池（2）
手少阴心经	2	27	1.19	神门（22）通里（5）
督脉	7	106	4.67	百会（78）风府（9）囟会（7）上星（7）命门（3）神庭（1）身柱（1）
手太阳小肠经	3	11	0.48	后溪（7）前谷（3）天窗（1）
总计	123	2269	100.00	

由表可知，在悬钟穴配伍治疗病证中，涉及的 159 个配伍腧穴中，包括十四经腧穴 123 个，各条经脉均有涉及。其中涉及腧穴数目最多的经脉为足太阳膀胱经，腧穴数目为 23。其次为足阳明胃经，腧穴数目为 15。再次为足少阳胆经，腧穴数目为 14。一方面足太阳膀胱经循行路线广，依据“经脉所过，主治所及”治疗范围也较大，膀胱经与督脉相通，可调节阳气，对机体整体状态进行调节；另一方面膀胱经背俞穴分布广泛，而背俞穴为脏腑之气输注于背腰的部位，与多个脏腑经气相通，故此经可治疗多种脏腑疾病。同时悬钟为胆经穴，“胆主骨所生病”，而膀胱与肾相表里，肾主骨生髓，可治疗胆经病变所引起的异常问题。选用胆经穴遵循了“本经取穴”的原则。选用任脉中相应部位的腧穴进行治疗，体现了一定的局部治疗规律。

5 刺灸法

5.1 针刺法

对于悬钟穴针刺法的研究，主要集中在针刺深度和留针时间，古代医籍记载较多，具体统计结果见表 22：

表 22　悬钟穴针刺法

	操作	古籍	频次
针刺深度	针入六分	圣济总录 1 针灸甲乙经 1 勉学堂针灸集成 10 针灸易学 1 普济方 2 针灸聚英 1 刺灸心法要诀 1 针灸资生经 2 针灸大成 5 神应经 2 类经图翼 2 针方六集 2 古今医统大全 2 医学纲目 2	34
	针三分	扁鹊神应针灸玉龙经 1 医学入门 1 针灸聚英 2	4
	斜入针二寸许	针灸聚英 1 针灸大成 3	4
	二寸半	针方六集 4 医学纲目 6 女科证治准绳 1	11
	横针寸五分，直透阴交上	针灸神书 1	1

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

	针五分	针灸聚英 2 医学纲目 1 女科证治准绳 1	4
	针七分	针灸聚英 2	2
	一寸半	医学纲目 2 证治准绳 · 疡医 1	3
	三寸半	医学纲目 1	1
	横针二分半	勉学堂针灸集成 1	1
	补五分	医学纲目 1	1
针刺原则	先针无病手足，后针有病手足	勉学堂针灸集成 1 针灸逢源 1	2
	左治右，右治左	普济方 1 医学纲目 1	2
	络刺	针方六集 1	1
留针时间	留七呼	圣济总录 1 针灸甲乙经 1 勉学堂针灸集成 10 普济方 2 针灸聚英 3 针灸资生经 2 针灸大成 3 类经图翼 2 针方六集 1 医学纲目 2	27
	留十呼	针灸聚英 2	2
	泻六吸	勉学堂针灸集成 2	2
	久留针	勉学堂针灸集成 1	1

结果：

据统计，古代医家对悬钟穴针刺法的针刺深度、针刺原则与留针时间的记载涉及 20 部古籍，总频次为 103。其中对针刺深度进行描述的频次为 66，描述种类也较多，有 11 种描述方法，记载最多的是“ 针入六分 ”，频次为 34，而对此说法记载最多的医籍为《勉学堂针灸集成》，频次为 10。相比较而言，对其留针时间的记载则较少，有 10 部古籍进行过记述，频次为 32，其中最为多见的是“ 留七呼 ”，频次为 27，也是《勉学堂针灸集成》记载最多，频次为 10。

分析：

针刺法的针刺深度与留针时间对于针刺疗效的取得具有重要意义。由历代医籍可以看出历代医家也比较重视此方面的研究，但记载最多的，被大家广泛接受的说法是“ 针入六分，留七呼 ”。除却对常规的针刺深度与留针时间论述外，古籍对有些疾患针刺时的原则也有所论述，如《针灸逢源》中“ 半身不遂 此由气血不周。一名偏枯是也。或但手不举口不能言。而无他症者。此中经也。各随其经络俞穴而针灸之。兼

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用药补血养筋。方能有效。百会 肩井 肩髃 曲池 手三里 列缺 风市 绝骨 足三里以上穴。先针无病手足，后针有病手足。”[28]的记述体现出了“先针无病手足，后针有病手足”的治病原则。《普济方》《针方六集》中记载了“左治右，右治左”与“络刺”的治病原则。同时“横针寸五分，直透阴交上”、“横针二分半”则体现出了针刺方向、透针刺法的问题。

5.2 艾灸法

经检索发现，对悬钟穴的艾灸法记载，主要集中在艾灸壮数方面，具体统计结果见表 23：

表 23　悬钟穴艾灸法

	操作	古籍	频次
艾灸壮数	三壮	太平圣惠方 3 普济本事方 1 勉学堂针灸集成 14 普济方 2 针灸聚英 7 黄帝明堂灸经 3 针灸资生经 2 针灸大成 1 神应经 2 古今医统大全 2 医学入门 1 续名医类案 2	40
	五壮	太平圣惠方 1 圣济总录 1 针灸甲乙经 1 勉学堂针灸集成 2 针灸易学 1 万氏家抄济世良方 1 普济方 3 刺灸心法要诀 1 黄帝明堂灸经 1 针灸资生经 2 针灸大成 6 神应经 2 针灸逢源 2 类经图翼 2 针方六集 2 神灸经纶 2 医学纲目 2 外台秘要 1 明医指掌 1 赤水玄珠 1 医学从众录 1 急救广生集 1	37
	七壮	勉学堂针灸集成 5 普济方 1 针灸聚英 2 针灸大成 3 外台秘要 1	12
	十四壮	普济方 1	1
	二七壮	神应经 1 针方六集 2 扁鹊神应针灸玉龙经 1 育婴家秘 1	4
	三五壮	文堂集验方 1	1
	三七壮	勉学堂针灸集成 1 普济方 1 类经图翼 1 针方六集 2	5
	二十壮	外台秘要 1	1
	二三十壮	病机沙篆 1	1
	五十壮	圣济总录 1 勉学堂针灸集成 1 普济方 2 针灸资生经 3 医学纲目 1 千金翼方 2 备急千金要方 1	11
	百壮	圣济总录 1 勉学堂针灸集成 6 普济方 2 针灸资生经 2 千金翼方 1 张氏医通 1	13

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

	二百壮	肘后备急方 1 圣济总录 1 普济方 1	3
	随年壮	普济方 2 针灸资生经 1 千金翼方 1	4
治疗原则与程度	灸疮	勉学堂针灸集成 2 普济方 1 黄帝明堂灸经 1 针灸资生经 1 针灸大成 2	7
	风在左灸右，右灸左	普济方 1 黄帝明堂灸经 1 针灸资生经 1 针灸大成 1 勉学堂针灸集成 1 身经通考 1 古今医统大全 1	7

结果：

根据表 23 可知，对悬钟穴艾灸法的记载涉及古籍 37 部，频次为 147，其中对艾灸壮数的频次为 133，最多的说法为“ 三壮 ”，频次为 40，次之为“ 五壮 ”，频次为 37，再之为“ 百壮 ”，频次为 13。记载最少的为“ 十四壮 ”、“ 三五壮 ”、“ 二十壮 ”、“ 二三十壮 ”，由《普济方》、《神应经》、《针方六集》、《扁鹊神应针灸玉龙经》、《育婴家秘》、《文堂集验方》、《外台秘要》、《病机沙篆》所述。除对艾灸壮数进行了记载外，古籍中对艾灸治疗某些疾病时的原则与治疗某些疾病应达到的程度也进行了研究。原则内容为“ 风在左灸右，右灸左 ”，而程度则为“ 灸疮 ”。

分析：

通过统计可知，与悬钟穴的针刺法相同，对其艾灸法记载最多的古籍也为《勉学堂针灸集成》，频次为 32。而且通过与针刺法的对比也可知，对艾灸法记载的古籍数目，与在历代文献中出现的次数均高于针刺法，由此可知，艾灸比针刺在运用悬钟穴治病防病的过程中更为多见。对于艾灸壮数记载最多的艾灸壮数为“ 三壮 ”和“ 五壮 ”。

5.3 刺灸禁忌

悬钟穴的刺灸禁忌论述较少，说法统一。主要是妊娠禁忌，首见于《备急千金要方》:“ 妊娠二月名始膏，无食辛臊，居处必静，男子勿劳，百节皆痛，是为胎始结。妊娠二月，足少阳脉养，不可针灸其经（如胆窍、丘墟、趺阳、绝骨、外丘、阳陵泉等穴是也。）足少阳内属于胆，主精，二月之时，儿精成于胞里，当慎护惊动也。”[9]。之后的《医灯续焰》、《济阴纲目》、《金匮启钥（妇科）》、《胤产全书》皆有此记载。

除运用常规的针刺与艾灸法治疗疾患外，古籍中对其他治疗方法，也有所提及，统计结果见表 24：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 24　其他治疗方法

方法	古籍	频次
以镵针针刺出血	类经 2 素问悬解 3 黄帝内经太素 1 黄帝素问直解 1 黄帝内经素问集注 1 黄帝内经素问 1 素问吴注 1 本草乘雅半偈 1 针灸甲乙经 1 针灸素难要旨 1 针灸逢源 1 医学纲目 1 证治准绳 · 杂病 1	16
三棱针刺出血	素问病机气宜保命集 1 勉学堂针灸集成 2 普济方 1 此事难知 1 医学纲目 2	7
以鈚针刺	普济方 1	1
掐	动功按摩秘诀 1	1
擦	动功按摩秘诀 1	1
静功	动功按摩秘诀 1	1
搓	针灸神书 1	1

结果：

由表可看出，对于悬钟穴的治疗除却针刺和艾灸外，还有“ 镵针针刺 ”、“ 三棱针刺 ”、“ 以鈚针刺 ”、“ 掐 ”、“ 擦 ”、“ 搓 ”、“ 静功 ” 此七种治疗方法。频次为 28。其中“ 镵针针刺 ” 有 13 部古籍记载，涉及频次 16。

分析：

“ 镵针针刺 ”、“ 三棱针刺 ”、《动功按摩秘诀》中“ 设有腿痛者，可于绝骨穴掐五、七十度，擦五、七十度，兼静功。”[29]；《普济方》中的“ 以鈚针刺 ”《针灸神书》中的“ 搓 ”，体现出了治疗方法的多样性与可选择性，可更好的满足疾病多样化的要求，选择适宜的针刺方法，达到更好的防治效果。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结　　语

本研究以《中华医典》（第五版）为检索源，运用现代计算机检索技术与人工检索查阅相结合的方式，对涉及悬钟穴的相关古籍条文进行统计和整理，总结了悬钟穴的有关内容，现资料分析结果如下：

1 研究结论

悬钟穴穴名有悬钟、绝骨、髓会、阳辅。其中以“绝骨”见载最多。悬钟一名最早见于《针灸甲乙经》云：“悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”[1]对悬钟穴的定位有直接定位与辅助定位两种定位方法，主要以体表标志法为主。同时某些描述，如：“在外踝上三寸宛宛中”也体现了古代的腧穴定位中具有体表形态这一明显特征。辅助定位记载较少。对悬钟穴的经脉归属问题，历代医家均无异议，皆认为其归属于足少阳经。

悬钟穴单穴治疗病证有 54 种，涉及科别有中医内、外、五官、儿科 4 种。其中优势病证科别为中医内科和中医外科。中医内科病证中，各个属系均有涉及，最多的是肢体经络病证和脾胃系病证。其中前者病证为 18 种，包括痹证、蹙足、痉证、风身重、脚气、肭髓病、复连病、胕酸冷、髓病、厄痹、痿证、膝胕痛、项痹、腰痛、阴急、伛偻、足不收、足缓难行；后者为 11 种，包括腹胀、纳呆、泄泻、便秘、奔豚、恶心、腹满、中焦寒热互结、吐酸、胃热、心腹胀满。悬钟穴单穴主治外科疾病，主要涉及疮疡疾病、肛肠疾病、皮肤疾病三类。最多的是疮疡疾病，包括疮疡、瘰疬、流注、痈、有头疽、附骨疽、疔疮。悬钟穴配伍治疗病证与其单穴主治病证有相似之处。治疗病证均涉及中医内科、外科、儿科、五官科，且主要为内科病证，其中肢体经络病证居于首位，治疗病证 13 种。儿科治疗病证均最少。但配伍治疗病证中增加了对中医妇科疾病的治疗。悬钟穴配伍治疗病证中，涉及的配伍腧穴较多，大部分为十四经穴位，使用频次较多的多为四肢部腧穴。涉及腧穴数目最多的经脉为足太阳膀胱经。

对悬钟穴针刺法的针刺深度、针刺原则与留针时间的记载中，最多的是“针入六分”、“留七呼”。对于某些疾病的针刺原则则有少量记载。对艾灸法记载，主要集中在艾灸壮数方面，最多的说法为“三壮”。古籍中对艾灸治疗某些疾病时的原则与治疗某些疾病应达到的程度也进行了少量记述。除却针刺和艾灸外，还有“镵针针刺”、

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“三棱针刺”、“以鈹针刺”、“掐”、“擦”、“搓”、“静功”此七种治疗方法。

2 问题与体会

本研究通过整理分析悬钟穴相关条文，较为全面的理清了悬钟穴的源流，归纳了其单穴和配伍主治病证等规律，总结了刺灸法特点。中医历史源远流长，针灸作为其中的一个重要组成部分，同样具有悠久的历史。在时代的前进中，由于经济、社会等原因，对于古代医籍的保存与传承难免有散佚或错误。而且笔者在检索、整理分析的过程中，对某些古籍中的较为模糊、笼统的记述分类，可能会受个人能力、知识的限制出现偏颇。

古代文献是历代医家对治疗经验的传承与总结，是指导临床的重要依据。因此为了得到更好的临床治疗效果，要重视对古代文献的发掘和研究。同时也要在此继承的基础上，不断拓展思路，创新技术，做到继承与创新的更好的结合。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 晋·皇甫谧编集,黄龙祥整理.针灸甲乙经[M].北京:人民卫生出版社, 2006.6:96.

[2] 高式国著.针灸穴名解[M].黑龙江:黑龙江科学技术出版社,1982:134.

[3] 明·徐凤撰,黄幼民,郑魁山点校.针灸大全[M].北京:人民卫生出版社, 1987.4:31.

[4] 明·吴崑撰,陈艳明,郝海燕,杨光点校,王丽平,李志亮,衣华强点评.针方六集[M].北京:北京科学技术出版社,2013.12:44.

[5] 宋·刘昉著.幼幼新书[M].北京:中国医药科技出版社,2011.8:461.

[6] 清·黄元御撰.黄元御医书十一种（上）[M].北京:人民卫生出版社,1990.7:655.

[7] 宋·赵佶敕编.圣济总录（校点本）[M].北京:人民卫生出版社,2013:2237.

[8] 明·杨继洲原著,靳贤补辑重编,黄龙祥整理.针灸大成[M].北京:人民卫生出版社,2006.6:385.

[9] 唐·孙思邈撰,高文柱,沈澎农校注.备急千金要方[M].北京:华夏出版社, 2008.7:42.

[10] 宋·赵佶敕编.圣济总录（校点本）[M].北京:人民卫生出版社,2013:2190.

[11] 宋·王执中编著,黄龙祥,黄幼民整理.针灸资生经[M].北京:人民卫生出版社,2007.7:242.

[12] 清·吴亦鼎辑,邓宏勇,许吉校注.神灸经纶[M].北京:中国中医药出版社,2015.1:79.

[13] 清·冯兆张纂集,王新华点校.冯氏锦囊秘录[M].北京:人民卫生出版社,1998:468.

[14] 日本·丹波元简撰.素问识[M].北京:人民卫生出版社,1984,3:213.

[15] 晋·皇甫谧编集,黄龙祥整理.针灸甲乙经[M].北京:人民卫生出版社,2006.6:236.

[16] 宋·王执中编著,黄龙祥,黄幼民整理.针灸资生经[M].第一版.北京:人民卫生出版社,2007.7:83-84.

[17] 清·黄元御撰.黄元御医书十一种（上）[M].北京:人民卫生出版社,1990.7:655.

[18] 元·滑寿著,李玉清主校.十四经发挥[M].北京:中国医药科技出版社,2011.1:42.

[19] 清·李学川著.针灸逢源[M].北京:中国医药科技出版社,2012.1:18.

[20] 清·李守先撰.针灸易学[M].北京:人民卫生出版社,1990.11:40.

[21] 明·杨继洲原著,靳贤补辑重编,黄龙祥整理.针灸大成[M].北京:人民卫生出版社,2006.6:331.

[22] 明·徐春甫编集.古今医统大全[M].北京:人民卫生出版社,1991.8:491.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[23] 明·杨继洲原著,靳贤补辑重编,黄龙祥整理.针灸大成[M].北京:人民卫生出版社,2006.6:212.
[24] 明·楼英编撰.医学纲目[M].北京:中国医药科技出版社,2011:212.
[25] 宋·王执中编著,黄龙祥,黄幼民整理.针灸资生经[M].第一版.北京:人民卫生出版社,2007.7:247.
[26] 清·吴亦鼎辑,邓宏勇,许吉校注.神灸经纶[M].北京:中国中医药出版社,2015.1:199.
[27] 明·楼英编撰.医学纲目[M].北京:中国医药科技出版社,2011:205.
[28] 清·李学川著.针灸逢源[M].北京:中国医药科技出版社,2012.1:232.
[29] 清·汪启贤,汪启圣辑,傅景新点校.动功按摩秘诀[M].北京:中医古籍出版社,1986.6:9.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

综　　述

悬钟穴的临床研究进展

悬钟穴又名绝骨穴,为足少阳胆经穴,又是八会穴之髓会。定位最早记载于《针灸甲乙经》。古代医籍对其适应症及临床应用记载繁多,在现代针灸临床中悬钟穴也应用广泛,可单用或配合其他诸穴治疗中风、眩晕、失眠、颈椎病、腰椎间盘突出症、痛经等多种病症。笔者统计整理悬钟穴相关文献，现综述如下：

1 内科病证

1.1 缺血性中风

陈文等[1]将 160 例缺血性中风患者按每组 80 例随机分为针刺组与对照组，每组均给与常规缺血性中风治疗,但针刺组在此基础治疗基础上加上针刺足三里和悬钟治疗,根据治疗前后 TCD 脑血管血流指数的变化情况来进行结果疗效评价。结果：针刺组临床控制 12 例，占 15%，显效 32 例，占 40%，有效 27 例，占 33.75%，无效 9 例，占 11.25%,总有效率为 88.75% ;对照组临床控制 6 例,占 7.5%,显效 26 例,占 32.5%,有效 29 例，占 36.25%，无效 19 例，占 23.75%，总有效率为 76.25%。两组比较疗效有差异。

1.2 中风后遗症

李亚东等[2]对 67 例中风后遗症足内翻的患者进行临床观察，其中 34 例用绝骨透三阴交的方法，33 例用传统刺法，两组比较，结果：治疗组痊愈 15 例，占 44.1%，显效 11 例，占 32.4%，好转 6 例，占 17.6%，无效 2 例，占 5.9%，总有效率为 94.1% ；对照组痊愈 4 例，占 12.1%，显效 6 例，占 18.2%，好转 7 例，占 21.2%，无效 16 例，占 48.5%，总有效率为 51.1%，由此可知两组比较疗效有显著性差异。

1.3 失眠

何旭东等[3]随机将 60 例失眠症患者分为治疗组和对照组各 30 例,治疗组采用悬钟穴透刺三阴交的方法，对照组则采用常规针刺。两组治疗皆每日 1 次,以 10 天为一疗程，共治疗 2 个疗程。根据治疗前后 PSQI 评分的变化及临床疗效:治疗组的总有效率为 90%，对照组的总有效率为 66.7%，可知两组差异有统计学意义。结论：悬钟穴透刺三阴交治疗失眠症有良好的临床疗效。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.4 头痛

郭学梅[4]以针刺悬钟穴为主治疗偏头痛 120 例，右手进针，左手拇指按压在悬钟穴下方，使循经感传至头颞痛处，针感越强越好，结果：痊愈 102 例,占 85%,好转 18 例,占 15%。

1.5 肌痉挛

凌建维[5]用针刺悬钟穴方法治疗突发性项肌痉挛 1 例，以针尖向上斜刺入 2 寸深，左手按压在穴位下方,令针感直达项部,15min 后，患者的项部肌肉明显松驰，疼痛明显解除，为巩固治疗效果，静止留针 20min 后出针。

1.6 颈性眩晕

赵娜[6]将 50 例颈性眩晕患者，随机分为观察组和对照组各 25 例，前者用百会、风府(益脑方)加悬钟穴治疗,后者取益脑方治疗。以针刺前后患者经颅多普勒超声(TCD)所示的基底动脉、双侧椎动脉、双侧小脑后下动脉血流速度的变化为依据，结果显示,观察组在改善椎动脉高流速型血流速度与改善小脑后下动脉低流速型血流速度上，幅度有大于对照组的趋势。

1.7 高血压

张为[7]用悬钟穴治疗高血压病患者 40 例，采用双侧取穴，针刺得气后则行平补平泻手法，然后留针 30min，10min 行针 1 次,每日治疗 1 次,以 10 次为一个疗程。同时治疗期间停用其它降压药物，以治疗前后血压变化为依据对比，结果：显效 20 例，比例为 50%,有效 17 例,比例为 42.5%,无效 3 例,比例为占 7.5%,总有效率为 92.5%。

1.8 高血脂

邓柏颖等[8]对 48 例高脂血症患者采用"谢氏功能保健灸"进行观察治疗。结果:临床控制 12 例，比例为 25%，显效 19 例，比例为 39.6%，有效 16 例，比例为 33.3%，无效 1 例，比例为 2.1%，总有效率为 97.9%。结论：足三里、悬钟两穴合用可以降低血脂，改善脑部供血的状态。

1.9 胆囊炎、胆绞痛采用

尚健[9]采用针刺悬钟穴方法治疗胁痛 32 例,行补虚泻实的手法,然后留针 30min,每 15min 行针 1 次,结果:显效 24 例，比例为 75%，缓解 5 例，比例为 15.6%，无效 3 例，比例为 9.4%，总有效率为 90.6%.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.10 尿潴留

张齐娟[10]等将 80 例患者随机分为观察组和对照组，每组各 40 例。对照组用腰椎间盘突出症术后护理常规护理，观察组则在此基础上加以用三阴交透刺悬钟，另配以黄芪注射液穴位注射三阴交，根据两组排尿情况进行疗效比较，结果：观察组疗效明显优于对照组，且起效时间也明显快于对照组。结论:采用三阴交透刺悬钟穴并穴位注射三阴交，对治疗腰椎间盘突出术后急性尿潴留是一种有效且非常可靠的治疗手段。

2 皮外骨伤科病证

2.1 骨折

刘学忠[11] 将 90 例骨折患者随机分为药敷绝骨穴组、药敷三阴交穴组和绝骨穴按摩组三组，每组各 30 例,三组分别进行 1 个月的此三种治疗。根据骨折患者复位和固定后疗效显示:药敷绝骨穴的方法可以促进患者的骨折愈合,有效率为 93.33%。且患者自觉疼痛消失的平均时间(天数)、自觉肿胀消失的平均时间(天数)较其他两组显著减短。

2.2 骨科术后

孙朝辉等[12]将 60 例骨科术后疼痛患者随机分为针刺组与药物组，每组 30 例。针刺组以针刺悬钟穴为主配以阿是穴治疗 30 分钟 药物组肌肉注封平痛新注射液 20mg，每日治疗 3 次。然后观察两组患者 48 小时内疼痛变化情况。结果:针刺组 24 小时优良率为 89.2%,药物组则为 81.4%；同时针刺组 48 小时优良率为 100.0%，药物组则为 96.3%。结论：针刺组的镇痛作用好于药物组。

2.3 骨质疏松症

何劲等 [13] 将 192 例骨质疏松患者随机分为针刺组和对照组，每组各 96 例。针刺组以针刺双侧悬钟穴、肾俞穴和命门穴,每日治疗 1 次,以 30 次为 1 个疗程,疗程间隔 3 天,共治疗 3 个疗程。对照组以口服骨松宝颗粒剂治疗,每日服用 3 次,每次服用 1 袋,连续服用 3 个月。共 186 例患者完成试验。以两组治疗前后症状及骨密度等指标改变为依据，由此可知针刺悬钟穴、肾俞穴和命门穴对治疗原发性骨质疏松症有显著的疗效,且无明显毒副作用。

2.4 扭伤

赵臣来等 [14] 单取绝骨穴治疗急性腰扭伤，针刺时，绝骨穴针尖略向上进针，使之得气后，行凤凰展翅之法，使得针感沿腓、膝股上行以至病所,结果：治愈 49 例，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

比例为 98%，好转 1 例，比例为 2%，有效率达 100%。其中有 31 例针刺 1 次则痊愈，有 16 例针刺 3 次痊愈，2 例针刺 5 次痊愈,1 例经 5 次治疗后疼痛减轻，但未痊愈，改用它法治疗。

2.5 腰椎间盘突出症

罗万东等[15]将急性腰椎间盘突出症患者 83 例随机分为治疗组和对照组，其中治疗组 41 例，对照组 42 例，对照组予以地塞米松联合甘露醇静脉滴注，治疗组则在此基础上加配以针刺后溪和悬钟穴,结果显示:治疗组有效率为 90.2%，对照组为 73.8%。结论:针刺后溪、悬钟穴对急性腰椎间盘突出症有肯定的疗效。

2.6 梨状肌综合征

舒洪文 [16] 运用腿三针治疗梨状肌综合征患者 75 例,使患者健侧卧位，患肢屈髋屈膝，使健肢伸直，针刺环跳穴用 75㎜ 毫针快速刺至一定深度，气至后再刺至深处，使有触电样酸麻胀针感传导，施以雀啄法 2-3 次，不要捻转勿伤神经。针刺阳陵泉、悬钟穴用 50㎜ 毫针直刺，使出现针感，然后施以相应捻转补泻手法，后留针 30min，每日治疗 1 次,12 次为一疗程。结果:治愈 55 例，占 73.33%；有效 18 例，占 24.00%；无效 2 例，占 26.70%；总有效率 97.33%。

2.7 肩周炎

蒋海英 [17] 治疗肩周炎 60 例，采用针刺悬钟透三阴交治疗。用患肩同侧悬钟穴，透至三阴交以不透出皮肤为度,施以强刺激提插捻转手法，同时嘱患者配合做上举、外旋、后伸等动作，针刺得气后留针 30min，每 10min 行针一次，1 天治疗 1 次,以 3 次为一疗程。其中痊愈 48 例，比例为 80%,显效 7 例，比例为 11.7%,有效 4 例，比例为 6.6%,无效 1 例，比例为 1.7%,总有效率为 98.3%。

2.8 落枕

程素利等[18]选用 35 例落枕患者,取听宫、绝骨(一侧病变取同侧，双侧受累者取双侧穴)以针感向患处扩散为佳,同时嘱患者配合活动颈部，活动幅度由小渐大。结果显示 35 例患者全部治愈,治愈率高达 100%。

2.9 颈椎病

王琼[19]选取正常组和颈椎病组各 20 例志愿者,均选取悬钟穴（右侧）直刺 0.8-1 寸,根据功能成像系统所动态观察的针刺前及针刺过程中所有受试者的脑功能区的变化为依据,可初步推测出针刺悬钟穴可以激活小脑和枕叶，可对颈椎病患者起到相应

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的治疗作用。

3 妇科病证

郑建宇[20]以三阴交透刺悬钟穴的方法治疗痛经 56 例。针刺三阴交透刺悬钟(若伴随症状严重者可加内关穴)，然后行捻转泻法，使之得气后留针 30min,以 1 周期为 1 个疗程。总有效率为 96.42%。

4 儿科病证

费裕朗等[21]以用手对压三阴交和悬钟的方法防治小儿抽风 30 例，施治力量大小以患儿体质差异而定,可以从一侧开始再交替点压另一侧，也可以两侧同时点压，一次治疗 2-5min。结果：显效 16 例，比例为 53.3%，有效 7 例，比例为 23.3%，无效 7 例，比例为 23.3%，总有效率为 76.7%.

综上所述,悬钟穴的单穴及配穴应用可发挥舒筋活络,疏肝利胆,补肾益髓等作用,临床治疗主要集中在内科病证、皮外骨伤科病证。对于妇科病证、儿科病证的记载比较少。同时对悬钟穴的施治方法现代主要采用针刺、艾灸、点按等,而古籍多以针刺与艾灸为主,由此可知对古籍的挖掘与整理,继承与创新还存在着一定的问题,应该在深化古代文献研究的同时,理论与实践相结合,进一步扩大悬钟穴的应用范围,以期更好的发挥其临床价值。

参考文献

[1] 陈文,顾红卫,刘兴勤,等.针刺足三里、悬钟对缺血性脑卒中神经功能的影响及其临床意义［J].中国康复医学杂志，2007,22(12):1110.

[2] 李亚东,熊杰.透穴治疗中风后足内翻 67 例［J].中国民族民间医药，2010,13:153.

[3] 何旭东,许建阳,刘静,等.悬钟透刺三阴交治疗失眠症 60 例[J].中国医学创新,2014, 36: 108-110.

[4] 郭学梅.针刺悬钟穴为主治疗偏头痛 120 例［J].中国针灸,2001,21(6);340.

[5] 凌建维.针刺悬钟穴治疗突发性项肌痉挛案［J］.针灸临床杂志,2005,21(5):57.

[6] 赵娜.针刺益脑方加悬钟穴对颈性眩晕椎—基底动脉血流动力学的影响[D].山东中医药大学,2012.

[7] 张为.针刺悬钟穴治疗高血压病 40 例［J].河北中医,2006，28(2):154.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[8] 邓柏颖,谢感共,罗本华,等.功能保健灸治疗高脂血症 48 例疗效观察［J].新中医,2002,34(9):48.
[9] 尚健.针刺悬钟穴治疗胁痛 32 例［J].针灸临床杂志,2003,19(6):48.
[10] 张齐娟,蔡兵,曹庭欣,等.穴位注射三阴交并透刺悬钟穴治疗腰椎间盘突出术后尿潴留疗效观察[J].中医临床研究,2015,10:127-128.
[11] 刘学忠.药敷绝骨穴对上肢闭合性骨折患者辅助治疗作用的临床研究[D].广州中医药大学,2010.
[12] 孙朝辉,冯彩霞.针刺悬钟配阿是穴治疗骨科术后疼痛［J].中国针灸，2007,27(12):895-897.
[13] 何劲,宋道飞,向楠.针刺悬钟、肾俞、命门穴对原发性骨质疏松症患者骨密度的影响及治疗［J].中医杂志,2009,50(2):147-149.
[14] 赵臣来,郭加利.独取绝骨治疗急性腰扭伤 50 例［J].针灸临床杂志,2003,19(3):37.
[15] 罗万东,常勇,郭海龙.后溪配悬钟穴治疗急性腰椎间盘突出症的随机对照研究[J].甘肃中医学院学报,2014,04:67-69.
[16] 舒洪文.腿三针治疗梨状肌综合征疗效观察［J].针灸临床杂志,2000,16(5):47.
[17] 蒋海英.针刺悬钟透三阴交治疗肩周炎 60 例［J］.现代中西医结合杂志,1999,12:2018.
[18] 程素利,李岩,焦召华,等.针刺听宫绝骨治疗落枕 35 例[J].四川中医,2013,02:122.
[19] 王琼.针刺悬钟穴治疗颈椎病患者的脑功能成像研究[D].湖北中医药大学,2013.
[20] 郑建宇.三阴交透刺悬钟穴治疗痛经 56 例［J］.新中医,1997.05:26-27.
[21] 费裕朗,费嘉.点按三阴交及悬钟穴防治小儿抽风 30 例［J].实用中医药杂志,2011,27(5):319.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附　录

晋·王叔和《脉经》
晋·皇甫谧《针灸甲乙经》
东晋·葛洪《肘后备急方》
隋·杨上善《黄帝内经太素》
唐·孙思邈《备急千金要方》
唐·孙思邈《千金翼方》
唐·王　焘《外台秘要》
宋·赵　佶《圣济总录》
宋·王怀隐《太平圣惠方》
宋·琼瑶真人《针灸神书》
宋·叶大廉《叶氏录验方》
宋·王执中《针灸资生经》
宋·刘　昉《幼幼新书》
宋·许叔微《普济本事方》
宋·杨士瀛《仁斋直指方论（附补遗）》
宋·张锐？孙兆？《鸡峰普济方》
宋·董　汲《脚气治法总要》
宋·周守忠《养生月览》
金·刘完素《素问病机气宜保命集》
金·刘完素《素问要旨论》
金·何若愚《子午流注针经》
元·窦桂芳《黄帝明堂灸经》
元·滑　寿《十四经发挥》
元·滑　寿《难经本义》
元·西方子《西方子明堂灸经》
元·王国瑞《扁鹊神应针灸玉龙经》
元·王好古《此事难知》
元·朱丹溪《丹溪手镜》
元·朱丹溪《丹溪心法》
元·窦汉卿《针经指南》
元·罗天益《卫生宝鉴》
元·危亦林《世医得效方》
明·徐春甫《古今医统大全》
明·徐彦纯《玉机微义》
明·张景岳《类经》

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

明·张景岳《景岳全书》
明·张景岳《类经图翼》
明·吴　崑《黄帝内经素问吴注》
明·吴　崑《针方六集》
明·王绍隆《医灯续焰》
明·李时珍《本草纲目》
明·朱　橚《普济方》
明·董宿原《奇效良方》
明·万表辑，万邦孚增补《万氏家抄济世良方》
明·高　武《针灸聚英》
明·高　武《针灸素难要旨》
明·杨继洲《针灸大成》
明·张三锡《经络考》
明·陈　会《神应经》
明·徐　凤《针灸大全》
明·翟　良《经络汇编》
明·沈子禄，徐师曾《经络全书》
明·刘　纯《杂病治例》
明·刘　纯《医经小学》
明·万　全《保命歌括》
明·李　梴《医学入门》
明·楼　英《医学纲目》
明·龚　信《古今医鉴》
明·孙一奎《赤水玄珠》
明·虞　抟《医学正传》
明·王肯堂《证治准绳》
明·王肯堂《女科证治准绳》
明·王肯堂《胤产全书》
明·万　密《育婴家秘》
明·汪　机《医学原理》
明·龚廷贤《寿世保元》
明·王九思等《难经集注》
明·卢之颐《本草乘雅半偈》
明·汪　机《针灸问对》
明·夏　英《灵枢经脉翼》
明·李中梓《内经知要》
明·李中梓撰，清·尤乘增辑《病机沙篆》
明·胡文焕《医学要数》

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

明·武之望《济阴纲目》
明·汪　机《外科理例》
明·马　莳《黄帝内经灵枢注证发微》
明·龚廷贤《万病回春》
明·陈　言《杨敬斋针灸全书》
明·秦景明《症因脉治》
明·皇甫中《明医指掌》
明·李时珍《本草纲目》
清·周学海《形色外诊简摩》
清·王　贤《脉贯》
清·李　濬《身经通考》
清·叶天士《类证普济本事方释义》
清·程杏轩《医述》
清·郑玉坛《彤园医书（妇人科）》
清·陈修园《医学从众录》
清·薛　雪《医经原旨》
清·高士宗《黄帝素问直解》
清·张志聪《黄帝内经素问集注》
清·陈士铎《外经微言》
清·张志聪《黄帝内经灵枢集注》
清·黄朝坊《金匮启钥（妇科）》
清·黄元御《素问悬解》
清·汪启贤，汪启圣《动功按摩秘诀》
清·黄元御《难经悬解》
清·郑梅涧《重楼玉钥》
清·吴　谦《刺灸心法要诀》
清·程鹏程《急救广生集》
清·佚　名《凌门传授铜人指穴》
清·廖润鸿《考正周身穴法歌》
清·廖润鸿《勉学堂针灸集成》
清·陈惠畴《经脉图考》
清·吴亦鼎《神灸经纶》
清·李学川《针灸逢源》
清·李守先《针灸易学》
清·唐宗海《中西汇通医经精义》
清·尤　怡《金匮翼》
清·张　璐《张氏医通》
清·顾世澄《疡医大全》

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

清·何梦瑶《医碥》
清·祁　坤《外科大成》
清·魏之琇《续名医类案》
清·徐大椿《难经经释》
清·徐大椿《兰台轨范》
清·莫枚士《研经言》
清·陈念祖《医学实在易》
清·赵术堂《医学指归》
清·丁　锦《古本难经阐注》
清·叶　霖《难经正义》
清·李　延《脉诀汇辨》
清·何　英《文堂集验方》
清·刘钟衡《中西汇参铜人图说》
清·张振鉴《厘正按摩要术》

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

致　　谢

感谢导师王锐教授在本研究完成过程中的悉心指导。导师对自己要求严格，以身作则；对学生谆谆教诲，指引人生；对患者耐心负责，排忧解难。他以夯实的理论知识，严谨的工作态度，让我为之钦佩；他以传道授业解惑的耐心，不断地鞭策我努力上进；他温润如玉的君子作风无时无刻的在潜移默化的影响着我的为人处事。

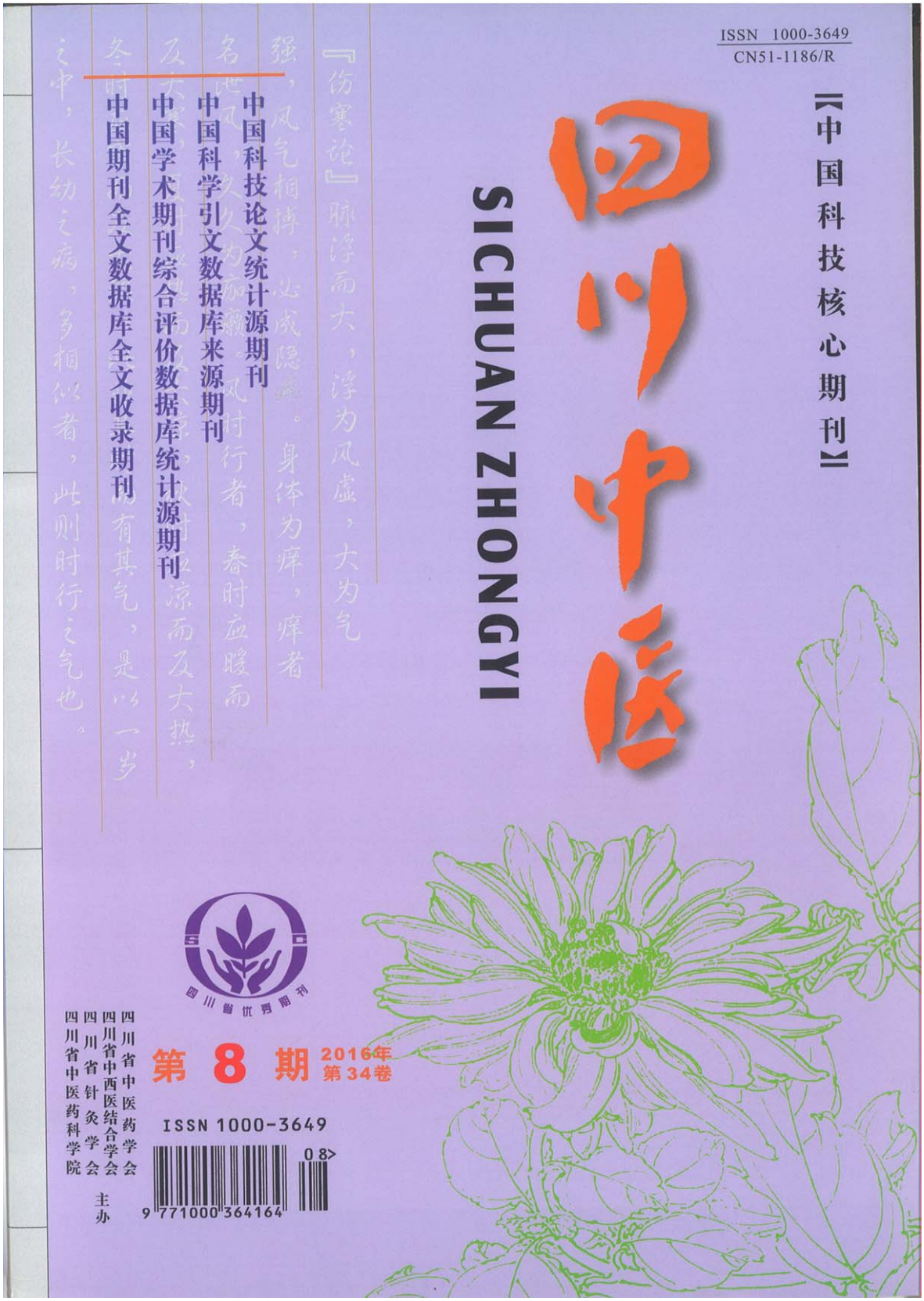
感谢同门师哥师姐在此论文写作过程中，不厌其烦的答疑解惑，给与指导和帮助。同时在此期间，时间安排紧凑，感谢师弟师妹的付出和体谅，让我可以顺利完成写作。

最后，对参与论文的评审、答辩，并为此提出宝贵建议的各位老师以及山东中医药大学及其附属医院的各位老师们致以最真诚的感谢！

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发表论文



(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

四川中医

SI CHUAN ZHONG YI

（月刊）

1982 年 10 月创刊

2016 年第 34 卷第 8 期（总第 393 期）

2016 年 8 月 15 日出版

主管：四川省中医药管理局

主办：四川省中医药学会
四川省中西医结合学会
四川省针灸学会
四川省中医药科学院

主　　编：杨殿兴

副 主 编：田兴军　周建伟（常务）

编辑部主任：胡绍刚

编辑出版：四川中医杂志编辑部

地　　址：成都市人民南路四段 51 号

邮政编码：610041

网　　址：http://sczy.cbpt.cnki.net

电子邮箱：schzhy@sina.com

电　　话：（028）85228345，85213152

编　　辑：姜冬云　李建才　邬宏嘉

英文编辑：姜冬云

发行范围：国内外公开发行

国内总发行：四川省报刊发行局

订购处：全国各地邮局（所）

邮发代号：62-26

国外发行处：中国国际图书贸易总公司

国外发行刊号：M823

广告经营许可证号：5101034000066

中国标准连续出版物号：ISSN1000-3649 / CN51-1186/R

印刷：四川煤田地质制图印刷厂

定价：10.00 元

责任编辑：胡绍刚

声明：为适应我国信息化建设，扩大本刊及作者知识信息交流渠道，本刊已被《中国学术期刊网络出版总库》及 CNKI 中国期刊全文数据库收录，其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付（本刊以寄送当期杂志的方式付给）。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我刊上述声明。

目　次

☆ 百家精粹 ☆

徐世芬针灸治疗失眠经验辑要 …… 王颖，徐世芬 1

杨东东教授梅花针配合针灸治疗带状疱疹后遗神经痛临床经验 …… 许长凤，邹懿，吴佩莅，等 3

胡天成教授临证应用黄芪经验 …… 王黄梅，周江 5

张毅教授治疗湿疹经验 …… 蒋莎莉 7

张永臣教授针刺结合脐疗法治疗精索静脉曲张经验 …… 王聪，于冰，张永臣 9

☆ 理论研究 ☆

浅析《伤寒论》对复杂病机证候的治疗原则 …… 邓森涛，苏琛 12

从震卦探析《伤寒论》厥逆证 …… 邓铭聪，胡伟雄，谢平霖，等 14

窦汉卿《流注通玄指要赋》浅析 …… 车依檀，张聪，张永臣 16

☆ 学术探讨 ☆

鼻渊的病机探讨 …… 庄瑞斐，周峰峰，顾庆华 19

基于阳明脉衰浅析高龄妇女生殖问题 …… 梁潇元，耿静然，夏宛廷，等 21

浅谈得气含义的三个方面 …… 管素梅，闫缪，谭砚，等 23

慢性浅表性胃炎的胃肺同治 …… 何勇，陈晓雯 25

逍遥散加减治疗糖耐量减低的探讨 …… 黄程程，刘强，张琳琳，等 27

运用病证结合思维辨治多囊卵巢综合征 …… 王泽文，彭杨芷，江泳 29

培补肝肾活血通络法治疗青少年近视的体会 …… 夏红 31

柴胡加龙骨牡蛎汤治疗登革热脑病临床探讨 …… 卢鸿基，王立新 32

黄芪降血压运用之临证浅析 …… 帅眉江，尹思源 34

论叶天士脾胃病理论在反流性食管炎治疗中的应用 …… 李瑞 36

杵针疗法调理背俞穴治疗外感发热 …… 晋松，孙剑峰，郭鸿，等 38

☆ 实验研究 ☆

太阴病脾阳虚证患者唾液分泌型 IgA 含量变化及舌苔蛋白双向电泳图谱研究 …… 姜冬云，魏巍，罗霞 40

复方白蔹面膜对兔耳瘀疮模型治疗作用的实验研究 …… 吴亚梅，华桦，黄志芳 43

千佛菌对 T1DM 模型小鼠 Th1 / Th2 类细胞因子基因异常表达的双向调节作用 …… 胡文波，席孝贤，贺新怀 47

四种温里药对离体肠收缩运动的影响 …… 陈仲祺，任礼锡，梁伟光，等 50

马甲子急性毒性 抗肿瘤作用及对免疫功能影响的初步研究 …… 余悦，白筱璐，雷玲，等 53

大株红景天对糖尿病视网膜病变眼血流的影响 …… 孟昕 56

☆ 临床研究 ☆

艾滋病热毒蕴结证蛋白组学标志物验证研究 …… 郭文利，舒发明，秦冰，等 60

宣白承气汤对急性肺损伤肺保护作用及炎性因子 呼吸力学指标的影响 …… 谭国柱，李敏，童晓萍 62

清肺化痰逐瘀汤对慢性阻塞性肺疾病急性加重期的临床干预研究 …… 史捷，喻敏，强宁侠 64

桑杷二百五汤治疗支气管哮喘的疗效观察及对 IL-18 IL-33 的影响 …… 蒋兰茂，于海建，朱秋玲，等 67

麻芩咳喘汤联合针刺对支气管哮喘急性发作期呼吸力学及细胞免疫功能的影响 …… 江成鹏，庞嘉言 69

养阴清肺汤联合孟鲁司特治疗小儿支原体感染肺炎后慢性咳嗽临床观察 …… 唐洁芬，余培煌 72

黄芪调营汤治疗小儿感冒后反复咳嗽的疗效及其对免疫指标 IgA IgE 的影响 …… 李穗华，钱丹 75

润肺调理汤联合 EP 化疗方案对晚期非小细胞肺癌疗效及对免疫功能的影响 …… 张慧贤，任连军，杨泽锋 77

柴葶利肺清瘀汤治疗慢性肺源性心脏病急性期临床观察 …… 韩向莉，娄志杰，邵岩 80

化痰降脂汤治疗高脂血症临床观察 …… 张洁 82

祛浊通络汤对高血压病血管内皮舒张功能的影响 …… 吴庆刚 84

桂枝赤芍方治疗心力衰竭的疗效及对心肌收缩力的改善作用 …… 杨建华，李复坚，余晓霞，等 86

健脑软脉颗粒对颈动脉斑块稳定性的临床研究 …… 杨霞 89

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

浅谈得气含义的三个方面

管素梅[1]，闫鏐[1]，谭砚[1]，王锐[2]
（1. 山东中医药大学，山东 济南 250014；2，山东中医药大学附属医院，山东 济南 250000）

摘要：“得气”最早来源于《黄帝内经》，对针刺疗效和预后有着重要作用。随着历代医家的不懈探讨与研究，中医针灸理论有了很大发展，而得气作为其中重要的一部分，其内涵也逐渐丰富。本文认为得气有三方面含义：首先气至针下，使医者和患者得到针感；其次可通过一定的手法使经气气至病所，更好的发挥针刺疗效；最后达到谷气至的整体调和阶段。

关键词：针刺；得气；针感
中图分类号：R 245 **文献标志码**：A **文章编号**：1000-3649（2016）08-0023-03

Discussion on Three Stages of Deqi of Acupuncture Connotation/*GUAN Sumei*[1], *YAN Liu*[1], *TAN Yan*[1], et al. //1. *Shandong University of TCM*, *Jinan* 250014, *China*; 2. *The Affiliated Hospital of Shandong University of TCM*, *Jinan* 250000, *China*）

Abstract: The earliest source of Deqi is derived from Huangdi's Conon of Medicine, which plays an important role in the acupuncture curative effect and prognosis. As the past dynasties doctor unremitting study and research, acupuncture and moxibustion theory of traditional Chinese medicine has made great development. And Deqi as the important part of it, it is rich in connotation also gradually. This paper argues that Deqi has three aspects of meaning: firstly, make the doctors and patients to get needle sensation; secondly, through the certain technique gets Qi to disease to play acupuncture curative effect better; finally, reach the overall harmonic phase.

Keywords: Acupuncture; Deqi; Needle sensation

“得气”一词最早来源于《内经》，即所谓“气至”。《素问·离合真邪论》中记载：“吸则内针，无令气忤。呼尽内针，静以久留，无令邪布。吸则转针，以得气为故……呼尽内针，静以久留，以气至为故。”《灵枢·终始》亦云：“凡刺之法，必察其形气……男内女外，坚拒勿出，谨守勿内，是谓得气。”《针灸学》中谈到得气，古称“气至”，近又称“针感”，是指毫针刺入腧穴一定深度后，施以提插或捻转等行针手法，使针刺部位获得经气感应。针下是否得气，可以从两个方面分析判断，即患者对针刺的感觉、反应和医者刺手指下的感觉[1]。由此可知得气为古今历代针灸医家所提及、重视，故笔者在导师点拨指导下，研读针灸古籍，结合临床实践，仅谈谈对得气含义的个人愚见。

1 得气的初级阶段

《素问·离合真邪论》曰：“真气者，经气也。”，《灵枢·刺节真邪》曰：“真气者，所受于天，与谷气并而充身者也。”可知经气由先、后天之气化生而成，充于周身。气主动，经气的运行，可以推动和调控脏腑生命活动的进行。“气至”一词最早见于《灵枢·九针十二原》：“刺之要，气至而有效。”气至针下是得气的初级阶段，即现今所谓针感中的一方面，可从患者与医者两方面进行判断。但针感一词文献中鲜有记载，古籍中多为对其的抽象描述，如《灵枢·邪气脏腑病形》记载“针游于巷”，《灵枢·九针十二原》提到“若行若按，如蚊虻止”等。随着研究分析的进展，近现代才逐渐有了较为具体的表述。

1.1 患者感觉 在描述患者感觉方面，如《素问·宝命全形论》描述为“见其乌乌，见其稷稷，从见其飞，不知其谁”，指出气至时，像乌云集合，像稷繁茂，如鸟之飞翔；除却文献中的这些形象描述，《素问·针解篇》提出：“刺虚则实之者，针下热也，气实乃热也；满而泄之者，针下寒也，气虚乃寒也。”同时还指出患者寒热的针感。黄涛[2]认为至清代《针灸内篇》凌云学术思想，才有了针刺后酸麻

参考文献

[1] 唐·王冰. 黄帝内经素问 [M]. 沈阳：辽宁科学技术出版社，1997：2，13，44，73

[2] 明·张介宾. 景岳全书 [M]. 北京：中国中医药出版社，1994：315，638

[3] 明·张介宾. 类经 [M]. 北京：中国中医药出版社，1997：51

[4] Heffner LJ. Advanced maternal age-how old is too old? [J]. N Engl J Med，2004，351（19）：1927～1929

[5] 金·李东垣. 脾胃论 [M]. 北京：人民卫生出版社，2005：4，32

[6] 明·李时珍. 本草纲目 [M]. 北京：华文出版社，2009：70，273

（收稿日期 2016-04-27）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

痛的记载："凡针入穴，宜渐次从容而进，攻病者，知酸知麻知痛，或似酸似麻似痛之不可忍者即止。"现代认为如针刺到肌肉、肌腱、关节、骨膜等部位则产生酸、胀、沉重等感觉；针刺到神经附近则产生麻感；针刺到神经干则发生触电感；针刺到毛囊、血管及四肢末端敏感部位则多出现痛感[3]。于书庄[4]将得气感分为酸胀感、麻与触电感、热感、凉感、抽搐感、痛感六类。而武连仲[5]提出酸、麻、重、胀、疼、凉、热、窜、动、抽10种针感，并且认为无论哪种针感的出现，都是得气的表现，其中凉感产生清热作用，热感产生温补作用，窜感产生行散作用，抽感有紧缩作用，从而丰富了针感的内涵。

1.2 医者感觉 《难经·七十八难》记载："当刺之时，必先以左手厌按所针荣俞之处……其气之来，如动脉之状。"宋代《太平圣惠方》针经序里记载："至病得气，如鲔鱼食钓，即得其病气也。"元代《标幽赋》中记载："轻、滑、慢而未来，沉、涩、紧而已至。既至也，量寒热而留疾；未至也，据虚实而候气。气之至也，如鱼吞钩饵之沉浮；气未至也，如闲处幽堂之深邃。"明代《针灸大全》记述："轻浮、滑虚、慢迟也。入针之后，值此三者，乃真气之未到也。沉重、涩滞、紧实也。入针之后，值此三者，是正气之已来也。"明代《针灸大成》"经络迎随设为问答篇"中记载："气来如动脉之状，针下轻滑。未得气者，如鱼之未吞钩，既吞得气，宜用补泻"，"若气不朝，其针轻、滑不知疼痛，如插豆腐；如神气至，针自紧涩。"《难经·七十八难》亦云"知为针者信其左，不知为针者信其右。"故当针刺得气时，押手指下亦能感觉到患者皮肤出现热感或凉感，或者感觉到患者肌肉抽搐、震颤等反应；当针刺不得气时，押手指下亦无任何特殊感觉和反应[6]。民国针灸大家承淡安在《中国针灸治疗学》[7]提到"医家运针，必待气至，病者觉针下酸重，医者捻动针柄亦觉针下沉紧之象是也"，而且提到在施行捻转手法时"每捻只针半转，非若轮之旋转不已，一方问病者觉有酸重散出否，苟只觉痛或痛与酸皆不觉，可将针微深入或退出些而捻运之，待患者觉酸重之后二三分钟。"此后便有了现代针感或得气感的雏形。

2 得气的中级阶段

"经脉所过，主治所及"，经络是一个相互联系的整体。针刺"气至针下"的初级阶段，仅局部有针感，并未使其循经络至病所发挥进一步的治疗目的。故通过一些催气，行气手法，使其气至病本所在，加以调之，可更好的发挥经气推动和调控脏腑生命活动的功能。有关研究[8]表明人群中普遍存在循经感传现象，无论是显性感传，亦或是隐形感传通过一定的刺激均可产生不同程度的趋向病所的特性，显性感传更易达到"气至病所"的效果。故"气至病所"可为得气的中级阶段。公元前3～4世纪的《阴阳十一脉灸经》中初步描述了经脉走行及病候，是经络形成的雏形，也是"气至病所"形成的雏形[9]。"气至病所"的术语则首见于元代《针经指南》"令病患吸气内针，捻针，使气下行至病所"，窦汉卿认为针刺过程中需用捻针手法促使气至病所。元代《针经摘英籍》中记载的"治偏正头痛……令人觉针下一道痛如线上至头为度"是"气至病所"的典型例子[10]。从针刺后经气的运动变化来看，《三国志·华佗传》有"下针，言当引某许，若至，语人，患者言，已到，后便拔针，病亦行差"等使经气从针下至病所的生动描述[11]。明代《针灸问对》中提出："得气，便卧倒针，候气前行，催气运至于病所。"指出了针刺得气后"气至病所"的操作方法。郑占武[12]等通过详读《内经》有关条文，印证于临床实践，认为"气至病所"存在着三个过程，即在针刺过程中，必须经过"得气"，"调气"，"行气"才能促使"气至病所"。现代《针灸学辞典》解释为"气至病所，指针刺感应趋向疼痛局部。"可见"气至病所"一词，乃后人之发明。"气"是指针下的得气感应，而"气至病所"则是指这种感应通过一定的手法，达到了病变部位[13]。近人对"气至病所"的论述，在《针刺手法一百种》指出："有的患者在针刺后不仅有局部针感，而且有循经上下传导的感应，针感沿着一定方向上下往来，甚至达到病变所在，这实际上是较强的针感，在针灸学上则称为气至病所。"

2.1 得气的最终阶段 《灵枢·终始》曰："所谓气至而有效者，泻则益虚，虚者脉大如其故而不坚也。坚如其故者，适虽言故，病未去也；补则益实，实者脉大如其故而益坚也，夫如其故而不坚者，适虽言快，病未去也。故补则实，泻则虚，痛虽不随针，病必衰去。"可知古籍《内经》此篇中气至是指以针刺前后脉象的变化作为针刺疗效和预后的客观指标。而《灵枢·终始》亦云："所谓谷气至者，已补而实，已泻而虚，故已知谷气至也。"指采用补法使正气实而采用泻法使邪气虚则证明谷气已至。可知谷气至是一种邪去，正盛气调的状态。而人体为一有机的整体，任何针刺治疗都应以调节整体为最终目标。故补泻气调之后的"谷气至"可作为得气的最终阶段。明代张景岳《类经·针刺类·得气失气在十二禁》提到的"则其邪气必去，正气必复，是谓得气"说明得气有时指的是补泻之后，气血调和，疾病向愈的状态[14]。明代《针灸大成》亦云："若针下气至，当察其邪正，分其虚实。经言：邪气来者紧而疾，谷气来者徐而和，但濡虚者即是虚，但牢实者即是实。此其诀也。"清代《勉学堂针灸集成》记载："候气有二：一曰邪气，一曰谷气。邪气来也，紧而疾；谷气来也，徐而和。"此皆可为整体调和谷气至的依据。

3 小 结

《灵枢·九针十二原》曰："刺之要，气至而有效，效之信，若风之吹云，明乎若见苍天，刺之道毕矣。"明代《针灸大成》指出："针若得气速，则病易痊而效亦速，若气来迟，则病难愈而有不治之

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

慢性浅表性胃炎的胃肺同治

何勇[1]，陈晓雯[2]
（1. 皖北煤电集团总医院，安徽 宿州 234000；2. 安徽中医药大学第一附属医院，安徽 合肥 230031）

摘要：慢性浅表性胃炎属于中医学胃痞、胃痛的范畴，一般认为，本病病位在胃脘，病机多为气机升降失司，胃失和降、胃失所养。胃肺在生理上密切相关，病理上相互影响。临床治疗胃疾，若顾及于肺，则往往可以提高疗效。胃肺同治则是根据胃肺的生理特点，采用降逆、滋养的方法进行辨治。

关键词：慢性浅表性胃炎；胃肺同治；和降胃肺；滋养胃肺
中图分类号：R 573.3+1　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1000-3649（2016）08-0025-03

Chronic Superficial Gastritis Treated from Stomach and Lung/*HE Yong*[1], *CHEN Xiaowen*[2]//1. *General Hospital of Wanbei Coal Group* (*Suzhou Anhui* 234000, *China*); 2. *The First Teaching Hospital of Anhui University of Traditional Chinese Medicine* (*Hefei Anhui* 230031, *China*)

Abstract: Chronic superficial gastritis belongs to the category of stomachache and stomach distention and fullness of traditional Chinese medicine, it is generally believed that this disease in the diagnosis, pathogenesis is Qi activity lifting more loss, gastric estrangement drop and the displaced. Stomach, lung is closely related to the physiologically and pathologically influence each other. Clinical treatment of gastric disease, if concentrate on lung, often can improve curative effect. Stomach, lung with therapeutic principle is based on the stomach lung physiology characteristic, adopt the method of inverse, nourish to syndrome differentiation.

Keywords: Chronic superficial gastritis; Treated from stomach and lung; Regulating and Dropping stomach and lung; Nourishing stomach and lung

慢性浅表性胃炎（CSG）是胃黏膜在各种致病因素作用下所发生的非萎缩性慢性炎症性病变。CSG 无典型及特异的临床症状，大多数患者表现为消化不良的症状，如反复或持续性上腹不适、饱胀、钝痛、烧灼痛等，无明显节律性，一般进食后较重；其次为食欲下降、嗳气、反酸、恶心等[1]。该病属于中医学胃痞、胃痛的范畴[2]。一般认为，本病病位在胃脘，与肝脾关系密切；基本病机为脾胃功能失调、升降失司，胃气壅塞或胃络瘀阻，胃失所养，不通则痛；辨证以辨寒热虚实为要点；治疗原则是调理

[5] 武连仲，张吉玲. 武连仲教授治疗脑病经验 [J]. 中国针灸，2000，20（1）：55～57
[6] 陈相明. 试论针刺得气 [J]. 中国民间疗法，2010，18（11）：11～12
[7] 承淡安. 中国针灸治疗学 [M]. 福州：福建科学技术出版社，2006：193
[8] 张缙，李永光，张文娟，等. 循经感传规律性的研究 [J]. 针灸学报，1991，01：7～20
[9] 苏美玲，陈铭，许金森. “气至病所”源流考及临床应用 [J]. 中华中医药杂志，2015，30（7）：2304～2306
[10] 刘书坤. 针刺得气及其衍变之探讨 [D]. 北京中医药大学，2005
[11] 傅西宁. “气至病所”初探 [J]. 中国医药学报，1987，01：7～10
[12] 郑占武，邵可森. 浅论“气至”和“气至病所” [J]. 陕西中医函授，1988，02：36～38
[13]《中医大辞典》编辑委员会. 中医大辞典（针灸，推拿，气功，养生分册）[M]. 北京. 人民卫生出版社，1986：47
[14] 林驰，马良宵，苑鸿雯，等. “得气”“气至”“针感”概念之我见 [J]. 中华中医药杂志，2014，09：2892～2895

（收稿日期　2016-04-12）

忧。”近代《金针梅花诗钞》亦说：“夫气者，乃十二经之根本，生命之源泉，进针之后必须细察针下是否已经得气。下针得气，方能行补泻，除疾病。”此皆指出“得气”是获得针刺疗效的和良好预后的关键。“得气”一直是历代医家研究和在临床追求的重要方面，随着研究和理解的逐渐深入，也形成了不同的理论观点，但笔者认为得气的含义有三个方面，“气至针下”是基础，之后通过一定的手法激发感传，有一部分人可出现显性感传，甚至达到“气至病所”，在此两者的基础上，通过虚补实泻的补泻操作亦可使气至而病愈达到“谷气至”的效果。

参考文献

[1] 石学敏. 针灸学 [M]. 北京：中国中医药出版社，2008：147
[2] 黄涛，孔健，黄鑫，等. 有关得气的误解：从历史回顾到实验研究 [J]. 中国针灸，2008，28（2）：105～109
[3] 安徽中医学院，上海中医学院. 针灸学词典 [M]. 上海：上海科学技术出版社，1987：348
[4] 袁宜勤. 试论针刺得气 [J]. 湖南中医学院学报，2006，26（2）：46～47

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net